图像诊脉法

TUXIANG ZHENMAIFA

样本库

R241.19
427
8

图像诊脉法

周华青 编著

图书馆

安徽科学技术出版社

1202168

责任编辑：胡世杰
封面题签：万　年

图象诊脉法
周华青　编著
安徽科学技术出版社出版
（合肥市九州大厦八楼）
邮政编码：230063
安徽省新华书店经销　　安徽芜湖新华印刷厂印刷
●
开本：787×1092　1/32　印张：3　字数：62,000
1991年3月第1版　　1991年3月第1次印刷
印数：00,001—7,250
ISBN7-5337-0637-5/R·107　　定价：1.60元

耄耋老人和他的《图像诊脉法》

（代序）

大约在三四年前的春夏之交，由一位老新闻工作者的引荐，得以拜识周华青老人。

周老出身贫寒，早年投身革命，解放后曾任省政府办公厅负责人、铜陵市副市长等职。几十年来，无论在战争年代或和平时期，他孜孜不倦研习岐黄之术，很有心得。他利用业余时间给周围同志看病，素有口碑；离休之后，他不享清福，却一心专攻中医脉学。据说他创造了一种图像诊脉法，极为灵验，一搭脉便可断病。

对此，我有点半信半疑。我学过一阵子中医，深知切脉非易。古人云："脉为医之关键，医不察脉，则无以别证；证不别，则无以措治，医惟明脉，则诚良医。诊候不明，则为庸妄，脉其可以弗辨乎哉！"（《古今医统大全》）脉学老祖师王叔和早有话在先，叫做："脉理精微，非言可尽，心中了了，指下难明。"切脉确实很玄，玄到"只可意会，难以言传"的地步。周老不仅能快速切脉，而且据病绘脉形，编写出讲义，开班授徒，搞得轰轰烈烈。其诊脉究竟如何呢？

耳听为虚，眼见为实。正好那天有《光明日报》科技部记者陈君、中医学院老师顾君一同前往。坐定之后，周老嘱我们稍事休息，以候心静脉定，接着便为我诊脉。他三指一搭，屏气静思，即刻脱口便说："你的膝盖有问题！"我为

之一惊。半年前，我因髌骨粉碎性骨折动过手术，当时尚未完全康复，但在平地上走路是绝对看不出来的。我与周老素昧平生，他也不可能知道我的病史。我心中暗暗称奇，表面上却未置可否。即请周老为陈君诊脉。不出几分钟，周老为陈君报出胃肠道等几种疾病来，我们这位见多识广的记者同志连连点头。

归途中，我与陈君、顾君探讨周老的诊脉术。顾君是行家，执言较为谨慎，他认为不能排除偶然性，必需有足够的病例，并且要作过统计学处理，才能下最后的结论。顾君言之有理。我也有些疑虑，怀疑周老的诊脉是否掺合了望诊的因素在内，但腿部外伤岂是面部望诊所能洞察的呢！陈君认为，周老视力不济，即使结合望诊，他的切脉断病也是很准的了。

此后，我又去拜访过一次。周老毕竟年事已高，且听觉不灵，交谈不易，他所介绍的图像诊脉法我只听了一个大概。

不久，他的儿子周秉山和弟子韦早平将周老的一本油印讲义送来，那就是这本《图像诊脉法》的雏形。

应当说，这本小册子是有独特见解的。它源于传统脉学，又有别于传统脉学。传统脉学，“切脉之道，全贵心灵手敏，活泼泼一片化机，方能因应。此在平时讲求精切，阅历既多，指下之妙，得之于心，不能宣之以口，实有此种境界。”（《医醇賸义》）周老将“不能宣之以口”的脉象用绘图方式表达，这种创新的勇气令人钦佩，我仔细体会他绘的脉象，有的几乎是传统脉象的“写意”，带有传统脉象的内在印记。也有的脉象，不结合具体病例是较难理解的。已收编在该书中的高血压、红细胞等脉象，可能实用价值并不

大，但对初学者熟悉这种诊脉方法也许会有帮助。

勿庸讳言，由于周老接触病例、病种的局限性，他的《图像诊脉法》所编入的病种还不多。此外，周老没有系统学过西医基础理论，对涉及的有些问题，讲得并不太清楚。这是要请读者明察的。作为周老的个人临床经验，不够完备，不够严密，也是难免的。我想，周老的这本小册子如果对进一步探索脉学有一点启发，这就是对作者最大的安慰了。

"夫脉者，医之大业也。"（《备急千金要方》）

脉学的研究正在深入。据说有的研究机构已设计出新一代诊脉仪，能客观描绘出各种脉象。这样描绘的脉象如能与特定的疾病相对应，那就为提高诊脉正确率、加快诊脉的速度带来了希望。周老的《图像诊脉法》如能与这类仪器相结合，可能会提高其科学性和可行性，也便于推广了。

——对于我这个门外汉的想法，不知周老以为然否？

亦步

1990年5月10日

前　言

我国脉学，历史悠久。数千年前，黄帝时代就有人提出脉学，研究脉学，运用脉学以诊病。

晋代王叔和著《脉经》将脉分为二十四种，《景岳全书》提出十六种脉象，明代医学家李时珍把历代脉学归纳为二十七脉，著为《濒湖脉学》。《诊家正眼》又增加“疾脉”，遂成二十八脉。此后，中国脉学就成为传统性的诊治手段。迄今千百年来，中医界诊治疾病基本上以王李脉学为准绳。

根据唯物辩证法原理，一切事物都是发展变化的。中医至今固守在二十八脉，没有新的发展，是令人遗憾的。并且疾病繁多，仅二十八脉，不能适应亿万人的治病需要。况且，这二十八脉“心中了了，指下难明”，难以掌握。往往对同一病人出现“三个名医三种脉”的现象。

为了人民的健康，祖国医疗事业的发展，发掘新脉学是很有意义的。因此，我在古代脉学的基础上，大胆探索，深入研究，经过几十年的专业和业余临床实践，发现了一些新的脉象，约140多种。用新脉象诊断疾病，经过X光、超声波、心电图、化验等反复验证，基本相符。

1975年，新脉学资料在安徽省铜陵市《科技专辑》发表。1981年4月，在合肥举办第一期新脉学短训班时，省科技情报研究所第四期科技情报专辑中，给以高度评价，认为新脉学是古代脉学的发展。同年7月，接受安徽宿县地区卫

生局、科协的邀请，在中医脉学训练班讲授新脉学的研究和特点等。安徽省广播电台曾在新闻节目中予以报道，认为：一脉一病，切诊准确。对症下药，疗效较好，并受到就诊单位和群众的好评。

言　　前

新诊脉法实际上是图像示脉法，或称之为“图像诊脉法”。图像诊脉法的优点，主要是脉像的形象化，脉位的具体化，所以病性、病位和病时容易确定，便于治疗。但是还有许多病脉未被发现，且已描绘的图像有的并非某种疾病，而是某种症状表现，或对某脏腑健康程度的评估。今后，我愿和其他有兴趣的同志在实践中继续努力，共同探索，使脉学的理论和切诊的准确性，得到进一步丰富和提高。

我写的这本《图像诊脉法》，中心内容是将特定的疾病表现出的脉象，用图示的方式表达出来。读者可通过对已知疾病的切脉对照图示，进行比较、琢磨、体会、熟悉、巩固后，即可反过来以脉象来推断疾病。当然，本书积累的病种还不多，经验还不丰富，理论也不成熟，仅仅是一家之言，难免有片面性、局限性，请读者批评指正。此外，我临床的常用方，并非与本书中诊脉断病一一对应；但考虑到有一定的临床运用价值，作为附录保留，特此说明。

本书在编写时，承周秉山、韦早平大力协助，万年、王亚洲等同志热情鼓励，特志谢忱。

周华青

目　录

寒霜老人和他的《图像诊脉法》（代序）…… 1
前言…… 5

上篇　图像诊脉法概述…… 1
一、图像诊脉法的缘起…… 1
二、图像诊脉法与传统脉学的比较…… 4
三、图像诊脉法答疑…… 7
1.图像诊脉法是怎样发现的…… 7
2.如何理解脉的概念…… 7
3.如何理解脉的作用…… 7
4.什么是脉象…… 7
5.什么是主脉和副脉？二者关系如何…… 8
6.脉象与神经交叉的关系如何…… 8
7.图像诊脉法有什么优点…… 8
8.图像诊脉法的准确率如何…… 9
9.图像诊脉法对切脉有何要求…… 9
四、图像诊脉法有关的问题…… 9
1.望闻问切…… 9
2.六脉部位的拇动及其确定……10
3.脉的活动方向……10
4.怎样把复杂的脉象具体化……11
5.切脉中的疑难问题……11
6.副脉的特点与病症的关系……12
7.关于脉象的形状……13
8.主副脉活动的基本规律……13
9.怎样用脉象来确定病位、特性、病时……14
10.脉象与病变处的神经交叉问题……14
11.神经、体液和脉象的关系……15
下篇　图像诊脉法图解……17

一、心脏脉象……[illegible]
二、肝、胆脉象……23
三、胃、肠、脾脉象……30
四、肺脏脉象……39
五、肾脏脉象……48
六、妇人脉象……53
七、其他脉象……57

附录　临床经验选编……65
一、临床用药原则……65
二、临床治疗大法……65
三、对患者的要求……65
四、临床常用方（52则）……66
五、临床小验方（20则）……79

上篇　图像诊脉法概述

一、图像诊脉法的缘起

我在青年时代，生了一场病，多少天不想吃饭，家里人焦心。父亲去请一位老中医来看看，哪晓得四次都请不来。为啥呢？一是瞧不起穷人；二是怕吃药给不起钱。有钱人家他主动跑去。这给我精神上很大刺激。从那时起，我就下定决心学习中医。1925年，我到安徽青阳县教书时，就跟一位许老医师学习中医。如背诵汤头、药性歌赋，研读《医宗金鉴》、《万病应变》、《瘟病条辨》、《伤寒论》、《陈修园四十八种》、《叶天士妇科》等。1930年到江苏省泗阳县史集教书时，跟名中医杨静夫先生学习中医，以学诊脉为主。我刻苦钻研，经过3年的苦学，进入了脉学之门。1943年到泗阳芦集教书时，我就兼行中医，运用古脉诊治，效果良好。我对中医的兴趣更加浓厚。1939年，我加入共产党地下组织时，仍以中医为掩护。公开入伍后，我忙于对敌斗争，学医就处于断续状态。解放后，我利用业余时间给人看病，探索脉象，研究脉学，终于在古代脉学[illegible]通过现代医学诊断的对照，结合望切问[illegible]发现[illegible]古前人的一些新脉象。

解放后，全国人民在党中央和毛主席的领导[illegible]积极医治战争创伤，进入了建设时期，恢复和发展生产。但是由于

图书馆

旧中国给人民留下贫困和落后，缺医少药，疾病流行。这时期，我工作虽然较忙，仍充分利用业余时间给病人医病，并钻研脉学，刻苦地探索新的脉象。

我对脉学的探讨和发现分为三个阶段：即从1950年到1955年为第一阶段。这期间以问为主，以切为辅，问切相结合。在临床时详细询问病史，认真体察脉证、辨证处方，给以治疗。例如有一患者睡眠不好，头痛，切其肝脉，脉来五至。脉症合参，知其肝热，肝阳上亢，上冲脑海而致头痛、失眠。据此，投以平肝潜阳、理气和血、安神药物而治愈。再如有一病人自述心慌、头晕、喘息，切其心脉，脉来缓慢，软弱无力，为贫血之象，即以养心、补血、强心安神而调治。临床上的成功，激励我进一步探索脉象的奥秘。

从1956年到1966年为第二阶段。这一阶段，医疗战线上有了较大的发展，医院的医疗设备逐步配套健全，物理诊断给临床带来科学依据，我对脉学的研究也取得了向纵深发展的条件。这时我就以科学鉴定为依据，通过现代医学器械及检验明确了疾病诊断，然后再结合病人症状，探讨脉象和脉位。比如，病人摄片诊为：右肺结核，我就在肺脉上探索，看肺结核究竟是什么脉象，经过反复的探索，在肺脉的左下边，发现有一条脉纹向下延伸，这才知道右肺脉的位置。同时按摄片位置探索结核脉的具体形状，感觉指下有点状的脉象，这是第一次的突破。后来，有一病人左肺空洞，我仍在肺脉上探索，发现肺脉左下部有条脉纹向右下倾斜，在脉的中间有个空泡形状脉，即认为它是空洞脉象，经过多次验证，均如前述。这一发现坚定了我对脉学的研究，并且突破了固有的二十七脉。在主脉的基础上发现了副脉，我就主攻了副脉。在两手寸关尺的脉位上，认真寻找它们的不同病症

的脉象，方法就是按部勘察病脉，并且记录下来，以便印证。在这阶段，我对已知病情的患者进行了广泛的接触，从中摸索出各脏腑病症的副脉。其中，为了探索高血压病是否有副脉，我对许多病人反复探查才得以证实。如：安徽省体委某同志患主动脉硬化、高血压。血压为20/13.3千帕(150/100毫米汞柱)，我就在他的心脉上探索，探来探去没有结果；第二次又来了高血压病人，该患者血压为22.6/13.3千帕(170/100毫米汞柱)。我又在他的心脉上探索，这时在此人心脉的左下方发现一条脉纹，长约4～5毫米；第三次在一个血压为24/16千帕(180/120毫米汞柱)的患者心脉上探索，发现在左下方同样有个脉纹，即认定为高血压脉象，并屡验属实。

从1966年以后为第三阶段。这一阶段，在各种病脉被掌握之后，我就以切为主，以问为辅。以现代医学诊断为对照，让病人做各种物理检查，验证是否属实。经过反复对照，基本相符，准确率达80～90%。

在这里我可以举一个例子。我为了探索红细胞的脉象，花费了几年时间。为啥要寻找红细胞脉呢？因为贫血多少与红细胞有关。探索出红细胞的脉象，即可了解到贫血的程度。但是红细胞是否能表现出脉象，又从什么脉位去发现它，还是个谜。我联想到肝是人体内的大化工厂，并具有特殊的功能，所以我每逢切到病人的肝脉时，就注意肝脉的上下左右，有无异常形状脉象。有一次，发现肝脉右上侧有几个小圆球形脉状，似乎有1毫米大小，向手指的方向排列整齐。我就假定它为红细胞脉象。又把一个小圆球形脉，假定为红细胞100万。叫贫血病人拿去化验对照，果然相符。经过屡验属实，才肯定下来。

二、图像诊脉法与传统脉学的比较

脉学为祖国医学的重要诊断方法之一，几千年来，经过历代学者不断研究和发展，从临床实践中积累了极其丰富的理论和实践经验。脉诊是以寸口诊法为主，分为二十七种脉象，以此察知身体内部的病变。古人把千差万别的脉象归纳到左右寸关尺六个部位是一个创举。《素问·宣明五气篇》中说："心主脉。"脉与心息息相关，心又与整体有密切关系，故身体有病，必然影响及脉。另一方面，脉中水谷之精气，流布经络，灌溉脏腑，流行四肢，贯注百骸。五脏气血也通行于脉而作用全身；气血脏腑发生病变，脉往往先受影响，有时在疾病还未显露出来之前，脉就有了变化。所谓是病即有是脉，病在脉后也。若夫病证未形，血气先乱，则脉在病先，诊脉可以预知将来必患之病也。

古代医学家对脉学历来是重视的。《素问·阴阳应象大论》说："善诊者，察色按脉……按尺寸观浮沉滑涩而知病苦……"。汉代张仲景把脉分为阴阳两大类，以大、浮、数、动、滑为阳脉，沉、迟、弱、细、微为阴脉。晋代王叔和著《脉经》分为二十四脉（浮、芤、洪、滑、数、促，弦、紧、沉、伏、革、实、微、涩、细、软、弱、虚、散、缓、迟、结、代、动）。唐代杨立操注解《难经》为二十三脉，元代滑伯仁《诊家枢要》分为三十脉（在前脉基础上加大、小、长、短、牢、濡、疾，去软脉）。明代李时珍著《濒湖脉学》，分为二十七脉。明代李中梓《诊家正眼》分为二十八脉（浮、沉、迟、数、虚、实、长、短、洪、微、细、濡、弱、紧、缓、弦、动、促、结、代、革、牢、散、芤、伏、

疾、滑、涩）。清代张石顽分为32脉。脉学大致不外乎以上内容。这说明古代医学家一贯珍视脉学，研究脉学，普遍认为脉学是诊病的指针，离开脉学就很难下药，即使处方治疗，也很难收到应有的效果。可是人的疾病繁多，古代脉学虽然起到了主导作用，但仅仅确定脉形、脉位的强弱、徐疾及脉动的方面，没有考虑到"副脉"，并且二十七脉不能概括几百种的病变需要，必须随着中西医结合的深入，在医疗实践中探索出一些新的脉象，来补充古代脉学之不足。

图像诊脉法是以祖国医学为理论依据的，在古代脉学的基础上，结合现代医学理论和医疗技术，经过实践—认识—再实践—再认识的过程逐步发展起来的，新脉学的特点如前所述，它的发现似乎有些离奇和偶然，其实不然，这些偶然中包括着必然。我们通过大量的临床实践验证了图像诊脉的准确性。任何科学必须接受实践的检验，图像诊脉也是如此。

图像诊脉法用于诊断疾病，可以代替一些目前运用的诊断技术，对于医疗条件较差的山区和乡村提供了很大的方便，对于早期诊断、早期治疗不无裨益。另外，图像诊脉法对于缩短中西医结合的进程，创立我国独特的新医药学也是有推动作用的。

当然，人类对自然的认识永远没有完结，图像诊脉法也有它一定的局限性，脉与病的关系十分复杂，根据古人的经验，脉证有相应的，也有不尽相同的，故又有"舍证从脉"或"舍脉从证"的说法。各种脉象虽有特定的内涵，但临床运用需要灵活掌握，应四诊合参，方可做出正确的诊断。图像诊脉法适应病种有限，故需结合必要的现代诊断技术。

至于副脉产生的机理，还须进一步探讨和认识。按控制

论说法，中医不是打开人体这个“黑箱”，而是靠输入信息通过反馈调整人体机能的。我们对人体这个“黑箱”的认识，还是远远不够的，所以对于产生主副脉的机理还没有完全进入自由王国；正如对经络的认识，它的实质是什么？古往今来一直是个诱人探索的生命之谜，至今还没有寻到一个满意的答案。

实践是检验真理的唯一标准。辩证唯物主义者确信人的认识能力是逐步深化的，只要是客观存在的事物，科学的发展终有一天会揭开它的秘密。对脉学的研究也是如此。图像诊脉法与古代脉学不同之处有以下八点：

1.古代脉学为二十七部脉象，图像诊脉法有一百多种脉象。它是在古代脉学的基础上发展起来的；

2.古代脉学只在原则上阐述了脉象活动的规律；图像诊脉法不仅阐明了主脉活动的规律，又说明了副脉活动的规律，即主副脉活动过程中内在的、本质的必然联系；

3.古代脉学只原则上确定了脉象，图像诊脉法既明确了脉象，又具体地确定了脉位；

4.古代脉学认为脉象都是上下垂直活动的，图像诊脉法认为心、肺二脉不是上下垂直活动，而是顺手臂方向左右搏动的；

5.古代脉学认为脉象的由来是“气动脉应”，图像诊脉法认为脉象是与神经体液调节有关的；

6.古代脉学只提出了心、肝、脾、肺、肾主脉脉象，有病有，没病也有；图像诊脉法论及了脾脉、腑脏和副脉脉象，病则有，无病则无；

7.古代脉学不可能涉及神经交叉与不交叉的问题；图像诊脉法对某些病变的诊断，参照了脏腑所属神经交叉与不交

又来确定病位；

8.古代脉学认为脾为脏脉，胃为腑脉；图像诊脉法认为胃为脏脉，脾为腑脉。理由是：胃脉是常有的，有病有，没病也有；脾脉是暂存的，病则有，无病则藏；并且通过胃脉才能找到脾脉。脾胃关系应颠倒过来。

三、图像诊脉法答疑

1.图像诊脉法是怎样发现的

图像诊脉法绝大多数是根据现代医学诊断，所提示的病性、病位、据病测脉，逐步积累，定出某病某脉，反过来，以脉诊病。这样一个一个地探索出新脉象。少数是从长期临床诊断实践中摸索出来的。

2.如何理解脉的概念

脉，就是两手腕寸关尺的动脉搏动，也就是该处的血液循环动态指感。凭脉断病，对病下药，疗效良好。如果仅仅问病下药，那是一种“侦察性”的治疗，假如侦察对了，也可以收到一定疗效，但可靠性不大。

3.如何理解脉的作用

脉的作用是反映脏腑健康状况。一旦脏腑发生了病变时，它就传递了病变信息，而医生右手中三指的末梢神经就将信息接收过来，便可知道什么病，病在哪里了。

4.什么是脉象

脉象就是脉的形状。有人认为脉象比较复杂，一病多

脉，或多病一脉，因人而异，变化多端。但我认为相应的病与相应脉必然有一种特定的内在联系。脉象各异。如果用图像诊脉法来衡量：胃溃疡是三角形脉象；而肝肿大脉象，则是弧形；胆囊炎则是珠形脉象等等。这些脉象将在下篇叙述。

5.什么是主脉和副脉？二者关系如何

主脉就是主宰五脏之脉，它在人手腕桡动脉寸关尺部位往返运动，反映五脏的状况。主脉的特点是长存的，有病时有，无病时也有。副脉是主脉的派生，它出现在主脉的周围，即主脉的上方或下方，前边或后边，左边或右边。副脉的特点是暂存，有病则现，无病则藏。然主副脉之间的关系是相互联系，相互依存，各自分工。但对脏腑疾病的反映，副脉较多，主脉较少。其原因譬如河流，往往主渠道畅通，淤塞干涸可能发生在支流。

6.脉象与神经交叉的关系如何

脉象诊断病位可能与神经交叉与不交叉有关。如果疾病的脏腑支配属于交叉神经者，则脉在左而病在右，脉在右而病在左；脉在上而病在下，脉在下而病在上。例如：肝左边肿大而脉象出现在肝脉的右边等。

7.图像诊脉法有什么优点

优点是：脉象的形象化，脉位的具体化、脉动的规律化，使人容易掌握，便于对症下药，收到应有的效果。具体地说：

①可以部分代替医疗仪器及化验诊断，收到诊断快、准

确性高的效果；

②便于早期诊断，早期治疗，防止疾病的发展；

③方便广大农村、山区等医疗条件较差的地区，为患者节约费用。

8.图像诊脉法的准确率如何

图像诊脉法切诊的准确率约在80--90%（指本书介绍的一百余种疾病范围内），经经现代医学诊断对照，基本相符（1981年6月在宿县地区卫生局、科协讲授新脉学时，诊断病人准确率曾作过统计）。

9.图像诊脉法对切脉有何要求

图像诊脉法对切脉的要求如下：

切心脉宜重，切肺脉宜轻，切肝、胃、肠脉宜中，切肾脉宜沉（如肾脏亏弱者可捞取）。假如违反切脉要求，则病性、病位就很难切准了。

图像诊脉法是我通过几十年的临床实践探索研究出的初步成果，也是中医学科的新课题，可以开拓人们在脉学方面的新见解和新认识，但仅是个人见解，尚未大面积推广，难免有些缺陷，甚至不妥之处，请读者不吝赐教，共同完善图像诊脉法。

四、图像诊脉法有关的问题

1.望闻问切

望闻问切是古代医学的经验总结。在科学不发达的时

代，诚为宝贵遗产。望闻问切，各有特点。望：是望神色、望形态；闻：是闻声音，闻气味；问：是问病情，问食欲，问现代医学诊断；切：是切出脉而知病状。这四者相互联系，必须全面了解。在一定条件下，可将某些病情归纳出来。问切结合，确定病情，对症下药，方可收到应有的效果。

2.六脉部位的搏动及其确定

脉位是反映脉象的“园地”，也是切诊脉象的部位。如果不熟悉这个部位，就无法了解各种脉象活动和变化，更无法认识病情之所在。

关于六脉搏动，在正常情况下，心脉五至（每呼吸一个周期跳动五次）。少于五至者，则为心动过缓；多于五至者，则为心动过速。少于三至者，则为心力衰竭。以上均有贫血缺氧之状。其他肝、肾、肺、胃、命门五脉，在正常情况下，一呼一吸同来四至，少于四至者为寒，多于四至者为热。

主脉，即五脏之脉。副脉是主脉的派生脉象，并在主脉的上下或左右出现。主、副脉相互有一定的联系，各有自己活动的规律。主脉大多反映病症的寒热虚实，阴阳表里。其他各类型的病症，均由副脉反映出来。此外，主脉是连续性的活动，患病时有，没病时也有。而副脉则是间断性的活动，有病则现，无病则藏。从脉学上来讲，六脉部位是切脉之门，是疾病之镜，至为重要。如果离开了六脉部位，则病性、病位、病时之脉就无法探索了。

3.脉的活动方向

心、肺二脉为何沿手臂方向左右搏动呢？主因是：肺有

二大叶，由支气管衔接，一呼一吸，左右弹动。心有两室，从舒张到收缩，从收缩到舒张，持续不断，左右跳动。腑脉的活动，大多附属于脏脉。如：心包络脉，附属于心脏脉的下半径中心，象“山”字形脉象，是向心脉下方活动的。胆脉，是附属于肝脉上半部右侧的圆形脉象，是向上弹跳的。大小肠脉，是在胃脉的上端左右活动的（左为大肠、右为小肠）。膀胱脉，是在右肾脉上端的一条脉纹上窜活动的，比肾下垂脉粗长一些。脾脉是附属于胃脉的左侧上部向左下倾斜活动。其他脉象可参看新脉象图解。

4.怎样把复杂的脉象具体化

原来我对古代脉学懂的不多，领会不深，只识浮、沉、迟、数、弦、濡、洪、弱等，其余脉象就领会得太少了。自从党中央提出西医学中医、中西医结合的方针后，我就运用唯物辩证法和实践论的思想武器，努力学习，刻苦探索，从实践中找答案。除依据古代脉学切诊外，我从实践中又探索出一些具体脉象，但这些脉象，是事先经过诊断病在哪个脏腑，什么病症之后，我就在哪个脏腑脉位上探索它的脉象，并以望闻问切相对照。这个病脉探索好了，再找同类病人再鉴定，再验证，再探索。久而久之，各种病脉就被掌握住了，搭手一切，便知什么病，这不就具体化了吗？

5.切脉中的疑难问题

我在切脉中遇到一些疑难问题，如：某些脉真象与假象分不清。有的可能是因为病性的复杂性，有的是未被认识的问题。其具体疑难是：

①病变处于萌芽状态时，脉上已有表现，但病人尚无症

状，实际上有病是真象，无病是假象，结果假象掩盖了真象。这就很难认定病情。

②病人已有病的症状，但脉象尚无反映，这可能是病在传递到脉的过程中受到某种障碍所致。病情也就很难认定。

③两种病脉出现在一个位置上，怎样确定它呢？如：主动脉硬化和高血压同在心脉的左下端一条线上。又如：胃左边扩大的弧形脉与左支气管扩大的弧形脉同在胃脉的右侧等，很难分辨清楚。

④有一种浮动脉象，时隐时现，不易察觉。

⑤阴极似阳，阳极似阴。有时阴阳脉难分。

⑥有的病人，一手有脉，一手无脉。有的两手均无脉（也无反关脉）。以上只能根据望闻问以治之。

6.副脉的特点与病症的关系

不同的病症，副脉的形状、位置也不同。副脉上窜的长形脉有四个：胸膜炎脉，在肺脉的上部左右两侧上窜四五毫米，脉来五至；胃下垂脉，由胃脉顶端上窜，上窜一毫米者，则下垂一厘米（由此类推），脉来四至；前列腺炎脉，由膀胱脉左右两侧上窜四，五毫米，脉来五至。膀胱炎脉，系由右肾脉顶端中心处上窜四五毫米，脉来五至或六至。

副脉下窜的长形脉有六个：二尖瓣狭窄脉，在心脉下半径的中心处下窜，长约四五毫米，脉来四至；右心房肥大脉，在心脉上半径右边处向左上倾斜，脉来四至。主动脉硬化脉，在心脉中心线的左侧，下窜约四五毫米，脉来四至；高血压脉，在心脉的下部左边下窜四五毫米。右肺有病，则在肺脉的下部左侧有条脉纹下窜，长约三四毫米，脉来四至。

副脉的圆形脉有四个：胆囊炎、妊娠、子宫内膜炎、球部溃疡等。但由于脉搏次数和跳动方向不同，病的性质也不同。如胆囊炎脉，在肝脉的右上角，向上弹跳，则脉来五至（如系胆结石，则脉来四至）。如孕脉，在肝脉的上端中心，向上弹跳，脉来四至（如怀孕三至四个月左右，则该脉下移，左右滑动；如到六个月之后，则该脉不现）。如子宫内膜炎脉，在肝脉的上端尖上，脉来五至或者六至。球部溃疡脉，在胃脉上半部左侧，向上弹跳，脉来四至。

7.关于脉象的形状

人体的一切机能都是在神经的控制和参与下完成的。脉象是由各种病变，通过神经、体液反映出来的现象。脏腑主脉的运动，在正常情况下是规则的，在病变情况下出现相应的改变。如果人的体质好，则六脉皆强；人的体质差，则六脉皆弱。表病则脉浮，里病则脉沉；虚病则脉细，实病则脉粗；寒则脉迟，热则脉数。但这些病态可以从五脏六腑本身之脉反映出来，而其他病态都是从副脉表现出来的。例如风湿性心脏病，在心脉的下半径出现混乱的脉纹；冠状动脉硬化，在心脉下半径中心出现线形的副脉，左右垂直活动；急性肝肿大，在肝脏的左侧或右侧出现长弧形的副脉，在左右两侧活动；右肺结核，在肺脉下半径左侧出现跳动急促的微点状副脉；左肺结核，则在肺脉下半径出现由左下向右下倾斜的副脉；胃溃疡，则在胃脉左侧下部出现三角形的副脉；肾结石，则在肾脉本身上下左右之间出现点块状的副脉。

8.主副脉活动的基本规律

人的心肺二脉左右活动，心脉一般脉来五至。肺脉一般

脉来四至。肝、肾、胃、命门等脉，上下垂直活动，一般脉来四至。以上是主脉活动的规律，如果哪个脏腑有了特殊病变时，则那个脏腑的主脉就派生出一种副脉。什么样的副脉就是什么样的病情，这是副脉活动的规律。如果病情发展了，副脉就增粗增长，或实大有力而急促，但基本形状仍保持；如病情好转或痊愈了，则副脉减轻或消失，这是副脉变化的规律。

9.怎样用脉象来确定病位、病性、病时

脉象是通过神经及血管的传递，反映病理变化的。血随气至，气血运行，循环不已。因此脉搏的跳动昼夜不止。但确定病位必须根据脉位的所在。但确定病性必须根据脉形与活动的方向，还必须根据脉的粗细长短，虚实强弱来判定。如脉象短细而弱，则病时较短；如脉象粗长而实，则病时较长。判断具体时间要靠实践经验。

10.脉象与病变处的神经交叉问题

人体的脏腑所对应的神经有的交叉，有的不交叉，是随着脏腑病变的位置而定。比如，左心室肥大，脉象不交叉，病在左，脉亦在左，脉来四至；冠状动脉硬化，脉是交叉的，副脉出现在心脉的下半径左右活动，脉来四至；心包炎，脉象不交叉，病在下，脉亦在下；风心病，脉是交叉的，病在上而脉在下；肝肿大，脉是交叉的，肝左边肿大，则弧形脉出现在右边，脉来五至；肝右边肿大者，则弧形脉出现在左边，脉来五至；二尖瓣狭窄，脉是交叉的，病在上而脉在下，脉来四至；主动脉硬化，脉不交叉，病在心脉的左上边，脉位

与病变处相一致；两肾之脉互不交叉，而两肾的本身之脉又交叉；如肾盂肾炎，脉在下而病在上，脉来五至。胃脉是交叉的：如胃溃疡脉是在胃脉的左下方活动，病在上而脉在下，脉来四至；球部溃疡是交叉的，病在下而脉在上（病在胃的下边，而脉在胃脉的左上边），脉来四至。大小肠炎症脉是交叉的：如大肠发炎，则病在左而脉在右；如小肠发炎，则病在右而脉在左，该脉同来五至。脾脉不交叉：如果脾肿大，该脉就由胃脉左上方窜出向左下倾斜；如脾脉窜出一个毫米，则脾大为一厘米（由此类推），脉来四至。

11.神经、体液和脉象的关系

神经、体液和脉象的关系，是相互联系，相互依存，相辅相成，缺一不可。假如没有神经，则脉象就无法体现，如果没有心脏的收缩和舒张来推动体液，神经就失去指挥的作用；假如没有脉象的信息，则疾病就无法诊断。总而言之，神经是人体的指挥系统，人如果离开了神经，则生命就要结束。体液是人身的“灌溉机”。人如离开了体液，则人的机体就干枯了。脉象是人身健康与否的晴雨表”，对检查身体是否有病、什么病以及病时的长短等有重要价值。所以说三者关系是相互依存，不可分割。但人体中到处是神经，从神经中枢分支为神经丛、神经枝、神经点、神经末稍，构成神经网络。神经随着人体的发育而成熟起来，又成为人体中的指挥系统（包括行动、语言、思想等等），但神经的功能范围不同，而它的活动形式也有所不同。医学重视对神经的作用，神经功能健全，则人的活动能力就健全，人的生命也将因此延续。必须认识神经的特殊功能。比如，人的病变大多

是内在的，是多类型的，在这种复杂情况下，即使是现代科学手段，想对各种病变都能够诊断，也是有困难的。但是通过神经、体液调节的传递，可将各种病变从脏腑脉象中反映出来，为诊断病变提供依据，从而确定诊断及医疗的方法。在研究脉学过程中，我曾对于脉怎样体现脉象感到奇怪。切脉仅是感觉，感来感去，怎样感出脉象来呢？好象有点玄。脉是千差万别的，取得共识，并准确表达，确实不容易。后来，我经过对前人脉学的研究和反复的探索，确信脉是神经的传递反映；脉不仅是主观感受出来的，而是客观的存在。脉虽千差万别，但它有一定规律，通过仪器，切闻结合，反复对照，表明各种病变存在着一定的脉象，而且可以用一定的方式表达出来，而图像诊脉法正是这样一种尝试。

下篇　图像诊脉法图解

切脉的部位　最常用的是“寸口”，即切按病人桡动脉腕后表浅部位。“寸口”又称“气口”或“脉口”，分寸、关、尺三部。掌后高骨（桡骨茎突）的部位为“关”，关前（腕端）为“寸”，关后（肘端）为“尺”。两手各有寸、关、尺三部，共有六脉。三部脉分候脏腑如下：右寸候肺，右关候胃，右尺候肾（命门）；左寸候心，左关候肝，左尺候肾。图像诊脉法也是采用三部六脉的基本原则。

图1 诊脉寸关尺部位示意。

切脉的方法　通常是病人坐在医生的右方，病人面对的方向与医生面对的方向相垂直。医生用右手食、中、无名三指依次切病人左右手腕寸关尺三个脉位处。脉的方位是以病人两臂的左侧为左，右侧为右；手臂朝肘端为上，朝腕端为下（如图2所标记，其他同，故均省略未标记，请读者注意）。读者可通过对已确诊的病例试验切脉，将感受的脉象与下列疾病的图示脉象进行对照、体会，熟悉后，即可反过

来，以脉象来推知疾病（注意，脉来多少至，每一至都重复前一至的过程，在图示中无法画出，因此有些图看来一致，其实不一样，应结合文字理解）。

一、心脏脉象

1.心脏的正常脉象

心脏的正常脉象，是顺手臂方向左右活动的。心脏主脉在人的一呼一吸中跳动五次（即脉来五至），并无副脉出现，即为心脏的正常脉象。（图 2）

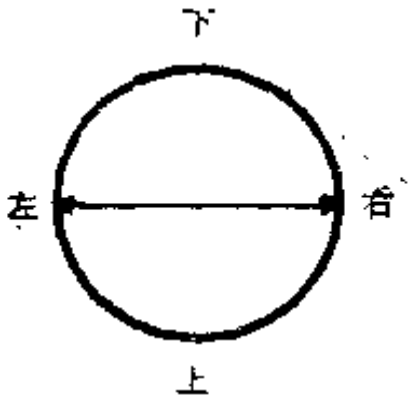


图 2

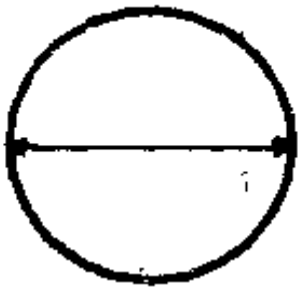


图 3

2.心脏衰弱的脉象

心脏主脉若脉来四至，则为心脏衰弱。（图 3）

3.心力衰竭脉象

心脏主脉若脉来一至、二至和三至，则为心力衰竭。（图 4）

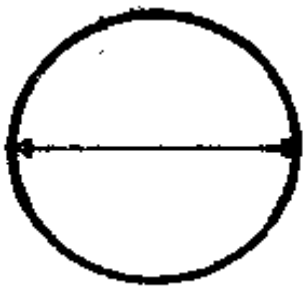


图 4

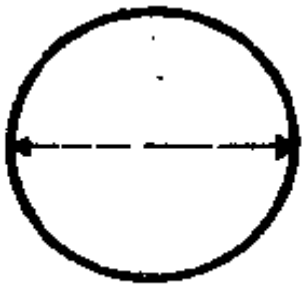


图 5

4.心律不齐脉象

心脏主脉若走走停停，停停走走，或强弱交替，则为心律不齐。（图5）

5.左心房扩大脉象

该副脉出现在心脏主脉的左边向右下倾斜，长约5毫米。若切到此脉，则为左心房扩大。（图6）

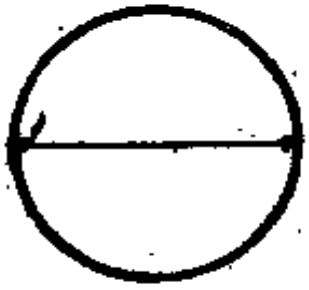


图 6

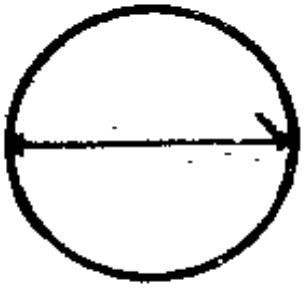


图 7

6.右心房扩大脉象

该副脉出现在心脏主脉的右边向左下倾斜，长约5毫米。若切到此脉，则为右心房扩大。（图7）

7.左心室肥大脉象

该副脉出现在心脏主脉的左边处，形似麦苞，上下跳动，急实顶手有力。若切到此脉，则为左心室肥大。（图8）

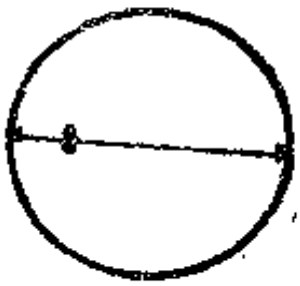


图 8

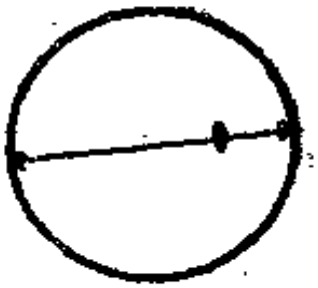


图 9

8.右心室肥大脉象

该副脉出现在心脏主脉的右边处，形似麦苞，上下跳动，急实顶手有力。若切到此脉，则为右心室肥大。（图9）

9.心包炎脉象

该副脉出现在心脏主脉的中心下半部，形似山状，脉来五至。若切到此脉，则为心包炎。（图10）

图 10

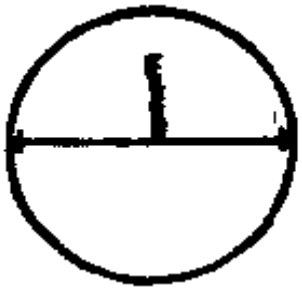


图 11

10.二尖瓣狭窄脉象

该副脉出现在心脏主脉的中心向下延伸，形似长线。若切到此脉，则为二尖瓣狭窄。（图11）

11.风湿性心脏病脉象

①风湿性心脏病（抗“O”增高为600单位左右）。

该副脉出现在心脏主脉中心下半径，有少量的混乱脉纹，即抗“O”增高到600单位左右。（图12）

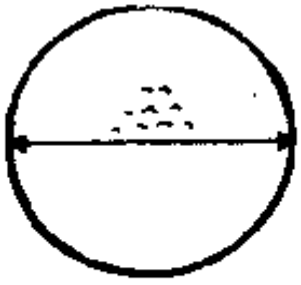


图 12

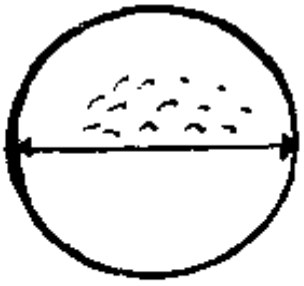


图 13

②风湿性心脏病（抗“O”增高到800单位左右）。

该副脉出现在心脏主脉中心下半径，有较多的混乱脉纹，即抗“O”增高到800单位左右。（图13）

③风湿性心脏病（抗“O”增高到1000单位左右）。

该副脉出现在心脏主脉中心下半径，有特多的混乱脉纹并顶手有力。即抗“O”增高到1000单位左右。（图14）

图 14

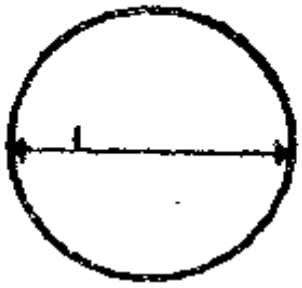


图 15

12.主动脉硬化脉象

该副脉出现在心脏的主脉左边，并向下窜，形似长线，较粗硬，长约5毫米。若切到此脉，则为主动脉硬化。（图15）

13.冠状动脉硬化脉象

该副脉出现在心脏主脉下半径中心下边与心脏主脉平行，形似线状，左右活动，脉来四至（若此病2年左右，如丝绒线；3年左右，如棉线；5年左右，如细麻线）。若切到此脉，则为冠状动脉硬化。（图16）

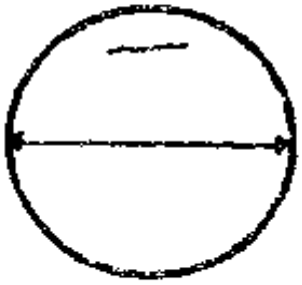


图 16

二、肝、胆脉象

1.肝脏的正常脉象

正常的肝脏脉象是顺手臂方向上下活动的，主脉在人的一呼一吸中跳动四次（即脉来四至），并无副脉出现。则为肝脏的正常脉象。（图17）

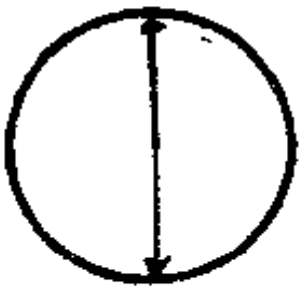


图 17

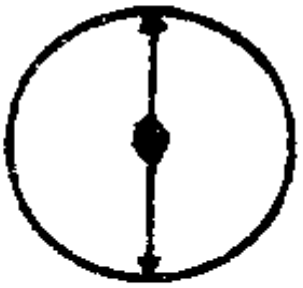


图 18

2.肝脏主体（前后径）肿大脉象

肝的主体中部发炎时，则肝脏主脉中心处向上弹跳，顶手有力，脉来五至或六至左右。若切到此脉，则为肝脏主体肿大。（图18）

3.肝脏右侧肿大脉象

该副脉出现在肝脏主脉的左边处，形似一条弧状，脉来五至。如脉扩1毫米，则肝大1厘米（由此类推）。若切到

此脉，则为肝脏右侧肿大。（图19）

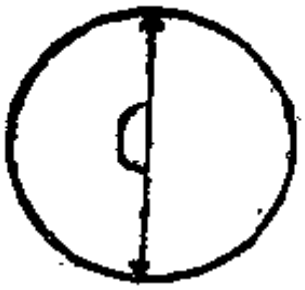


图 19

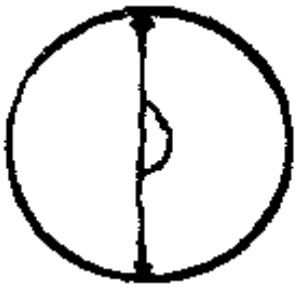


图 20

4.肝脏左侧肿大脉象

该副脉出现在肝脏主脉的右边处，形似一条弧状，脉来五至。如脉扩1毫米，则肝大1厘米（由此类推）。若切到此脉，则为肝脏左侧肿大。（图20）

5.肝脏左右侧均肿大脉象

该副脉出现在肝脏主脉的左右两侧，各成一条弧形，左右活动，脉同来五至。如左右两侧各脉扩1毫米，则肝脏左右各肿大1厘米（由此类推）。若切到此脉，则为肝脏左右两侧均肿大。（图21）

6.肝肋下肿大脉象

该副脉出现在肝脏主脉上端左边处，形似一条较粗的脉纹，左右活动，脉来五至。如肝肋下肿大1厘米，则脉粗1毫米（以此类推）。若切到此脉，则为肝脏右肋下肿大。（图22）

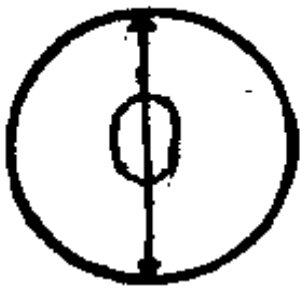


图 21

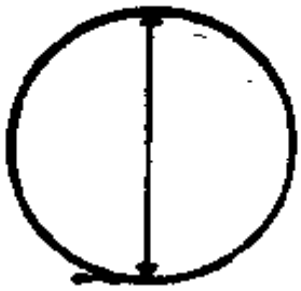


图 22

7.肝脏剑突下肿大脉象

该副脉出现在肝脏主脉的上端右边处，形似一条较粗的脉纹，左右活动，脉来五至。如肝脏剑突下肿大1厘米，则脉粗1毫米（以此类推）。若切到此脉，则为肝脏剑突下肿大。（图23）

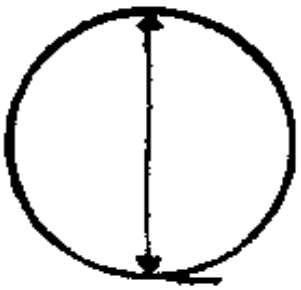


图 23

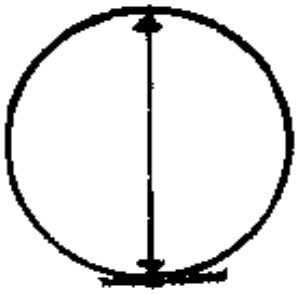


图 24

8.肝脏剑突下和肋下均肿大脉象

若肝脏剑突下和肋下均肿大，则肝脏剑突下和肋下副脉同时出现，形成一条左右活动的连接副脉，两脉同来五至。（图24）

9.肝气郁结脉象

该副脉出现在心脏主脉之上，肝脏主脉之下，形似气泡状，顶手有力，脉来五到六至。若切到此脉，则为肝气郁结。（图25）

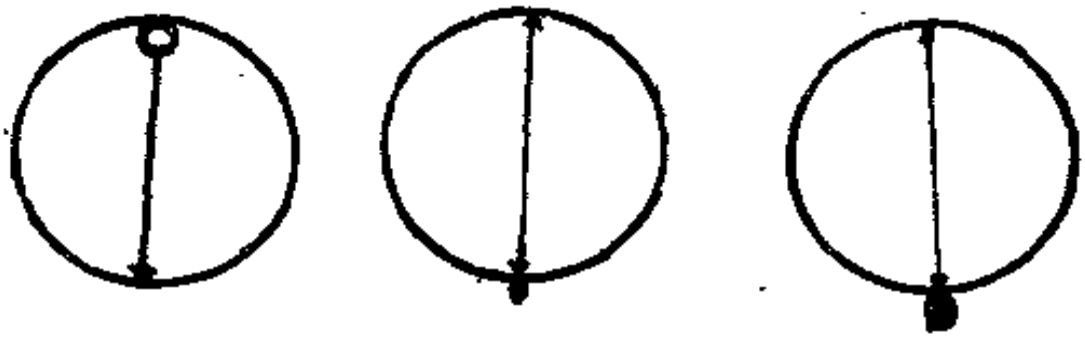


图 25　　图 26　　图 27

10.肝下垂脉象

该副脉出现在肝主脉上端中心处，形似点状或垂状，脉来四至。若切到此脉，则为肝下垂。（图26、27）

11.肝部疼痛脉象

肝部疼痛时，肝主脉必然跳动急促，似切绳索，或顶手

有力，并在肝主脉的左边或右边出现若干条形似细线的副脉，脉来五至以上。若切到此种脉象，则为肝部疼痛。（图28）

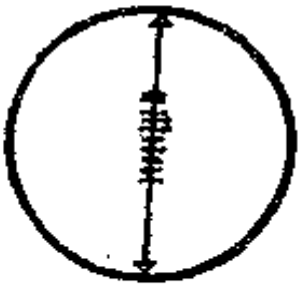


图 28

图 29

12.肝硬化脉象

①初期肝硬化，或肝边缘硬化，肝主脉的脉纹较粗，脉来五至以上；

②中期肝硬化，肝主脉的脉纹粗硬，脉来八至以上；

③后期肝硬化属于腹水，脉象不明。（图29）

13.肝脓肿脉象

该副脉出现在肝主脉的左边或右边。似圆形或长条形，脉洪而急，五到六至。若切到此脉，则为肝脓肿。（图30）

14.阴性肝炎脉象

由寒邪引起的肝炎，为阴性肝炎，该脉以肝主脉为准。若切到肝主脉脉细而弦，脉来五至，则为阴性肝炎。（图31）

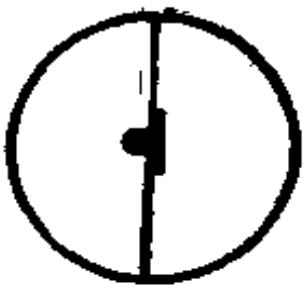


图 30

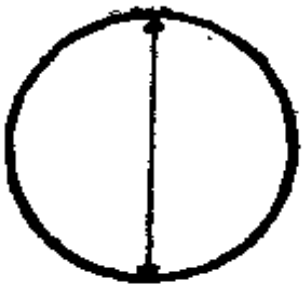


图 31

15.阳性肝炎脉象

由邪热引起的肝炎，为阳性肝炎。该脉以肝主脉为准。若切到肝主脉促而弦，脉来五至以上，则为阳性肝炎。（图32）

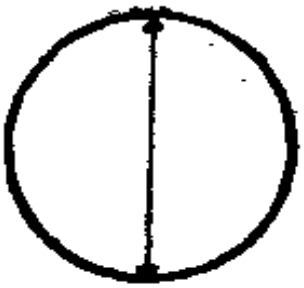


图 32

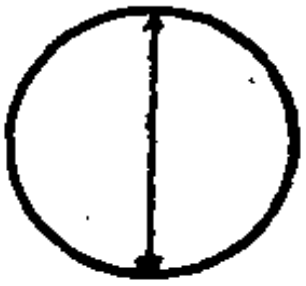


图 33

16.急性病毒性肝炎脉象

由于病邪感染肝部，形成病毒性肝炎。该脉以肝主脉为

准。若切到肝主脉，脉急有力，脉来六至左右，则为急性病毒性肝炎。（图33）

17.黄疸性肝炎脉象

由于胆道阻塞，胆汁不能进入十二指肠，以至漫延全身，有部分胆汁侵入肝部，阻碍肝的气血不能正常运行，造成黄疸性的肝炎。若切到肝主脉，脉弦而促，脉来五到六至，则为黄疸性肝炎。（图34）

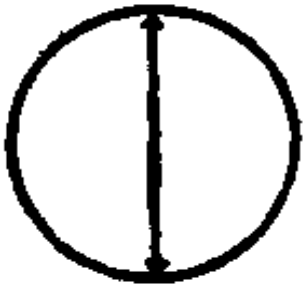


图 34

图 35

18.肝癌脉象

肝癌初期：肝主脉脉象不明；肝癌中期肝主脉脉象与麦芒相似；肝癌后期肝主脉脉象与钢针相似。（图35）

19.胆囊炎脉象

该副脉出现在肝主脉右边上角处，有一种质软而圆的脉象，向上弹跳，脉来五至。若切到此脉，则为胆囊炎。（图36）

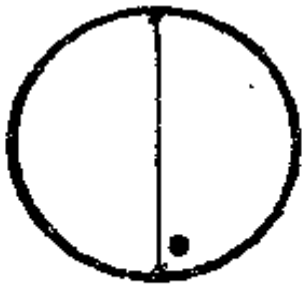


图 36

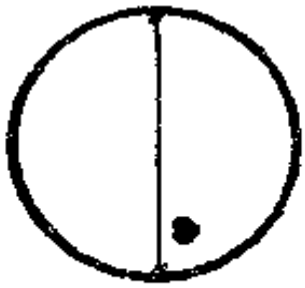


图 37

20.胆结石脉象

该副脉出现在肝主脉右边上角处，有一种质硬如石，或疏松不等形状（似砂石）的脉象，脉来四至。若切到此脉，则为胆结石。（图37）

三、胃、肠、脾脉象

1.胃的正常脉象

胃的正常脉象是顺手臂方向上下活动的。胃的主脉在人的一呼一吸中跳动四次（即脉来四至），并无副脉出现，则为胃的正常脉象。（图38）

2.胃炎脉象

如果胃家受寒之后，则气血郁结，逐渐形成炎症。轻者脉来五至，重者脉来六至。（图39）

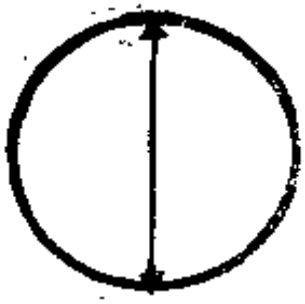


图 38

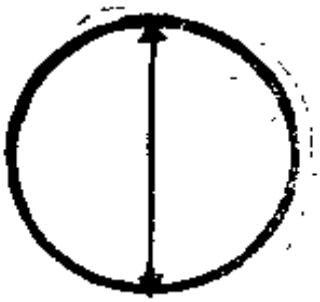


图 39

3.胃寒脉象

胃主脉往来三至为寒。浮则虚寒，沉则实寒。（图40）

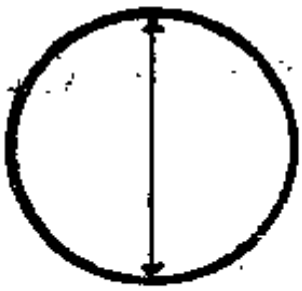


图 40

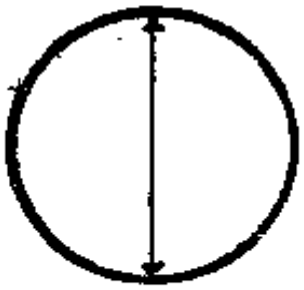


图 41

4.胃受重寒脉象

凡是胃受重寒者，大都以体强自诩，喝冷水、吃冷物、

顶暴雨，严重刺激胃神经，使气血不能通畅运行，导致胃痛、呕吐、恶寒发抖，脉沉三至，紧促有力。（图41）

5.贲门炎脉象

该副脉出现在肺脉之上，胃主脉下端中心处，形似圆球，左右活动，脉来四至。若切到此脉则为贲门正常脉象。

①若贲门发炎，则该脉洪大有力向上弹跳，脉来五至；如炎症较重者，则脉来六至。

②若贲门衰弱，则该脉细微无力，脉来四至。（图42）

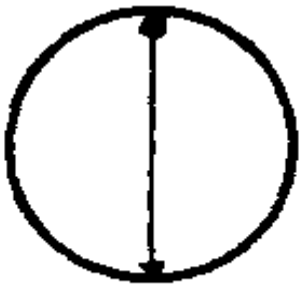


图 42

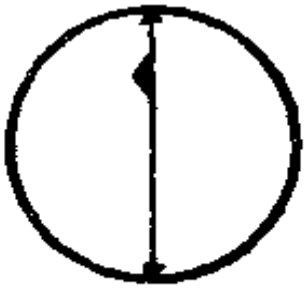


图 43

6.胃溃疡脉象

该副脉出现在胃主脉的下部左边或右边处，形似三角。若该副脉出现在胃主脉的左边，则溃疡出现在胃的右边；若该副脉出现在胃主脉的右边，则溃疡出现在胃的左边。若该副脉形似半个三角形，胃溃疡时间约1年半左右；已形成三角形者，则胃溃疡时间约3年左右。若胃家溃疡，主脉仍为四至；溃而发炎者，则主脉为五至。（图43、44）

7.球部溃疡脉象

该副脉出现在胃主脉左边上部，形似圆球状，脉来四至。若切到此脉，则为球部溃疡。如果溃疡痊愈，则在溃疡脉位置上出现疤结形状。（图45）

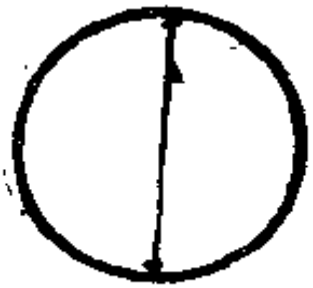


图 44

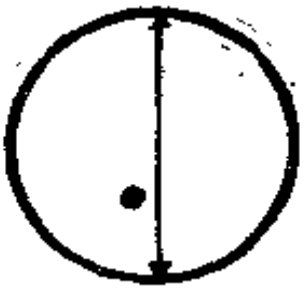


图 45

8.十二指肠溃疡脉象

该副脉出现在胃脉上端左边，形如一条短粗的脉状，脉来四至。若切到此脉，则为十二指肠溃疡。（图46）

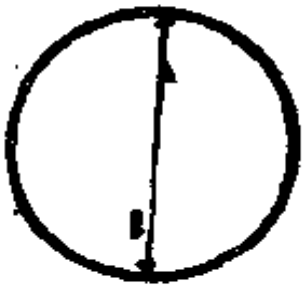


图 46

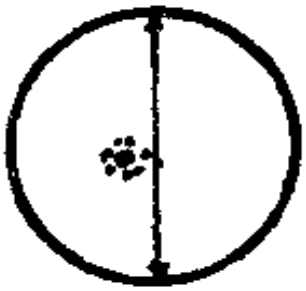


图 47

9.幽门溃疡脉象

该副脉出现在胃主脉中部的左边（在十二指肠球部外侧），形似葡萄状，脉来四至。（图47）

10.中脘衰弱脉象

该副脉出现在胃主脉中间，形似马鞍，即上下两头脉正常，胃脉中部呈现凹形脉状，脉仍四至。若切到此脉，则为中脘衰弱。（图48）

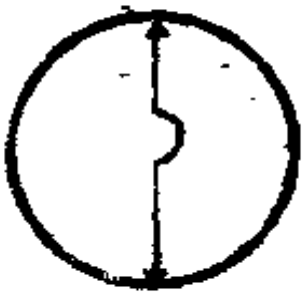


图 48

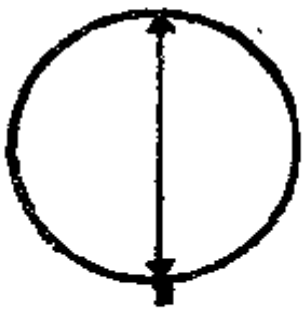


图 49

11.胃下垂脉象

该副脉出现在胃主脉上端中心处，形似一条很粗的脉状与肾主脉相接，脉仍四至，若上窜1毫米，则胃下垂1厘米，以此类推。（图49）

12.胃植物神经紊乱脉象

在胃脉的上下左右出现长短不一和零星的副脉，则为植物神经紊乱脉象。胃主脉仍为四至。（图50）

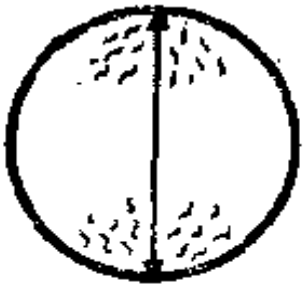


图 50

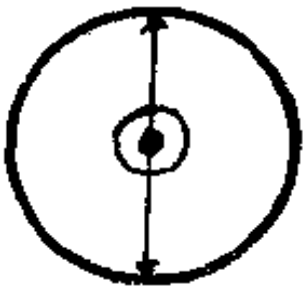


图 51

13.胃胀脉象

该副脉出现在胃主脉的中心，形似鼓状，向上顶手有力，脉仍四至。若切到此脉，则为胃胀。（图51）

14.胃扩张脉象

①若胃右部扩张，则在胃主脉的左侧出现一条弧形的副脉。（图52）

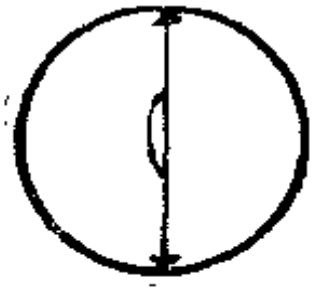


图 52

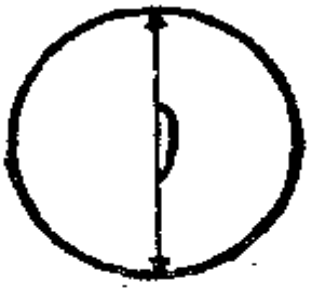


图 53

②若胃左部扩张，则在胃主脉的右侧出现一条弧形的副脉。（图53）

15.急性胃中毒脉象

若胃家中毒，则疼痛难支。此脉在胃脉的平面上，出现从右向左转动较急的大环形副脉，逆时针转动。（图54）

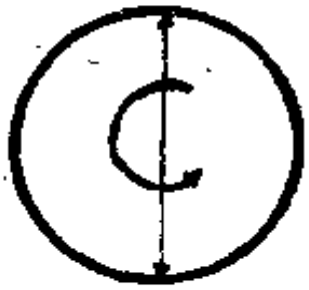


图 54

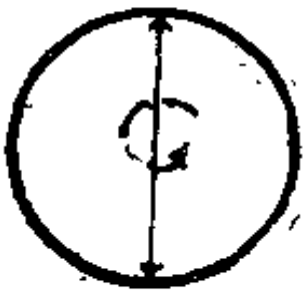


图 55

16.慢性胃中毒脉象

该脉与急性胃中毒脉很相同，但该副脉是断续旋转，脉来四至，其症状：不定时的疼痛。（图55）

17.脾肿大脉象

该副脉出现在胃主脉左边上角处，有条脉纹向左下倾斜，则为脾肿大副脉，脉仍四至，如脉纹长约1毫米，则脾肿大1厘米，由此可类推。如脾肿大很厉害并有炎症，则脉来五至以上。（图56）

18.左结肠炎脉象

该副脉出现在胃主脉上端左边，形似一条左右活动的长

脉，来往五至，则为左结肠发炎。如结肠有寒，则脉来三至。（图57）

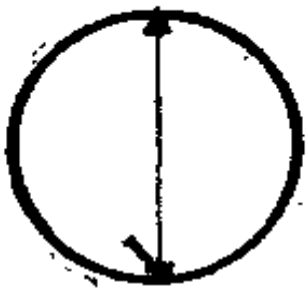


图 56

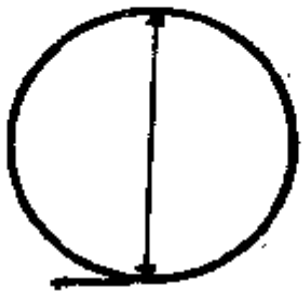


图 57

19.右结肠炎脉象

该副脉出现在胃主脉上端右边，形似一条左右活动的长脉，来往五至，则为右结肠发炎。如结肠有寒则为三至。（图58）

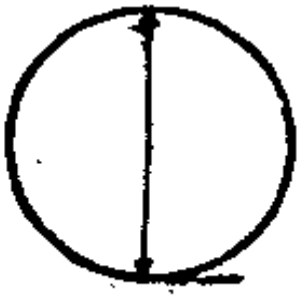


图 58

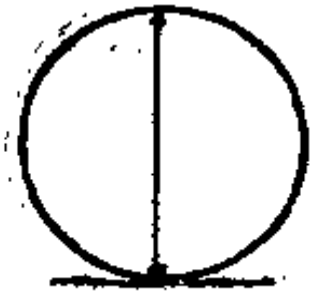


图 59

20.左右结肠同时发炎脉象

若大小肠同时发炎，则在胃主脉上端大小肠炎副脉同时

出现，连接成一条左右活动的长条脉，往来五至。如大小肠有寒，则往来三至。（图59）

21.左右结肠气滞脉象

①若大肠气滞，则在胃主脉上端左边副脉（即左结肠炎脉）上出现气泡形脉。脉来四至。（图60）

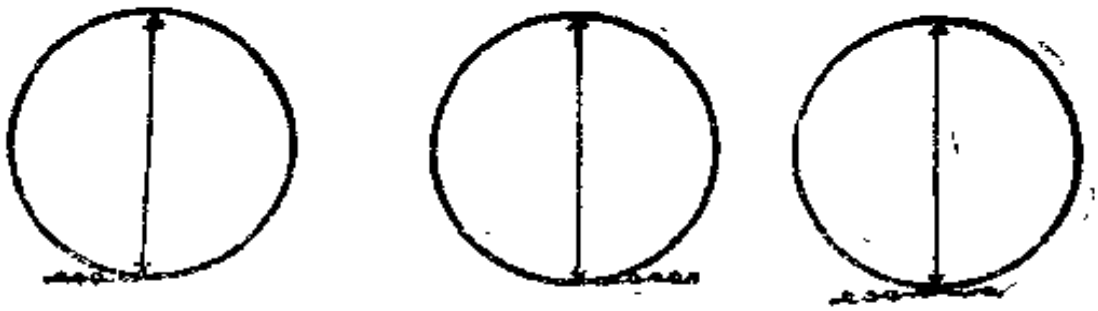


图 60　　图 61　　图 62

②若小肠气滞，则在胃主脉上端右边副脉（即右结肠炎脉）上出现气泡形脉。脉来四至。（图61）

③若左右结肠同时气滞，则在胃主脉上端左右两边的副脉（即大小肠副脉）上同时都出现气泡形副脉。脉来四至。（图62）

22.胃肠息肉脉象

该脉在胃肠脉之中，形如谷粒，坚硬如锁，脉来四至。（图63、64）

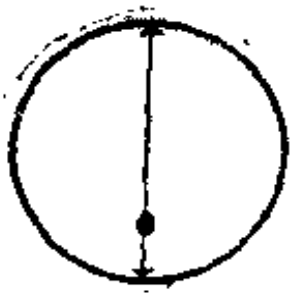


图 63

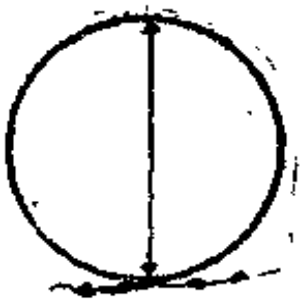


图 64

23.阑尾炎脉象

该副脉出现在胃主脉上部左边处，形似一条细长的脉状。来往五至，但胃主脉仍为四至。（图65）

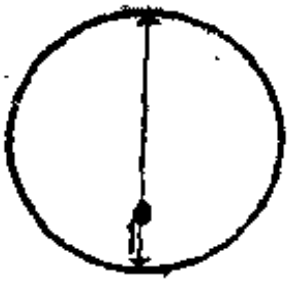


图 65

四、肺脏脉象

1.肺脏的正常脉象

肺脏的正常脉象，是顺手臂方向左右活动的。肺脏主脉

在人的一呼一吸中跳动四次（即脉来四至），并无副脉出现，则为肺脏的正常脉象。（图66）

2.右肺疾病脉象

该副脉出现在肺主脉的左侧并向下窜，形似一条线状。脉来四至。若切到此脉，则为右肺有病。（图67）

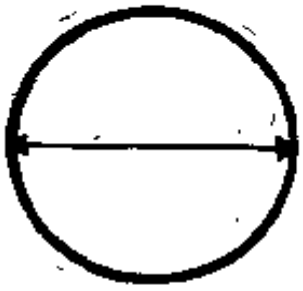


图 66

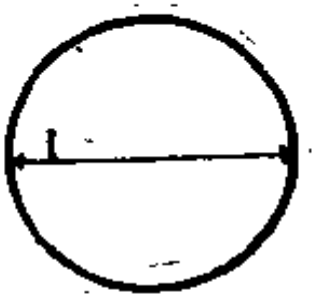


图 67

3.左肺疾病脉象

该副脉出现在脉主脉的左侧，并向右下方倾斜窜出一条线形副脉，脉来四至。若切到此脉则为左肺有病。（图68）

4.左右肺同时有病脉象

若左右肺同时有病，则肺主脉左侧下窜的两条副脉同时出现，两脉同来四至。（图69）

5.浸润型肺结核脉象

①如果右侧肺部有结核病灶，则在肺主脉左侧下窜的细

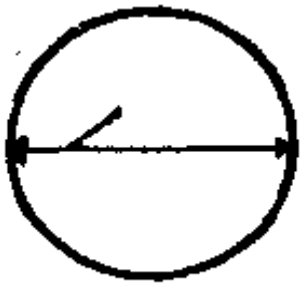


图 68

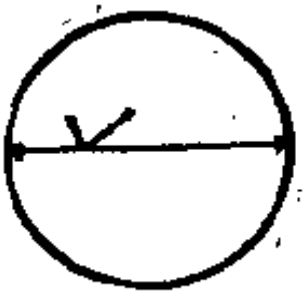


图 69

线形副脉周围出现微点状的脉象，并且跳动急促。（图70）

②如果左侧肺部有结核病灶，则在肺主脉左侧向右下倾斜的细线形副脉周围出现微点状脉象，并跳动急促。（图71）

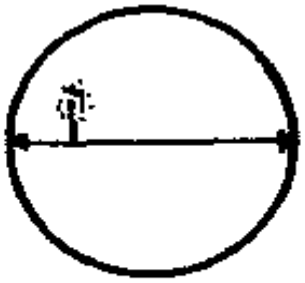


图 70

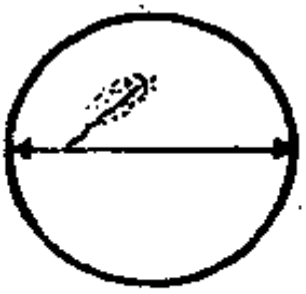


图 71

③如果左右侧肺部均有结核病灶，则在肺主脉左侧向下窜出的两条细线形副脉均有微点状脉象，并且跳动急促。（图72）

6.肺结核钙化前期脉象

从肺主脉左侧向下窜出的肺结核副脉，如微点状脉消失，并发生形态上的变化：即由细而长，逐渐转化为短而粗，并由五到六至逐渐转化为四至，来往稳定，则为肺结核钙化前期了。（图73、74）

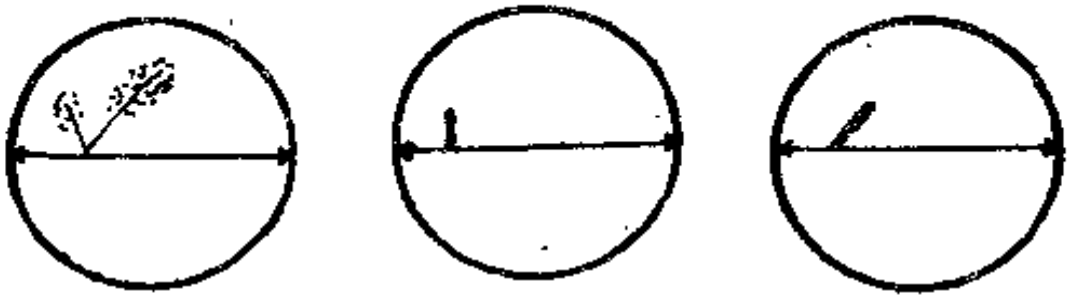


图 72　　图 73　　图 74

7.肺结核钙化期脉象

肺结核病灶，如果吸收钙化了，则在肺主脉左侧下窜的肺结核副脉上，出现硬点状脉象（哪侧肺上有结核，则在哪侧肺结核副脉上出现），脉来四至。（图75）

8.肺结核部分钙化脉象

肺结核病灶，如果部分钙化了，尚有部分没钙化，则在肺主脉左侧下窜的肺结核副脉上出现的硬点状脉象，来时现硬点状脉象，去时则无。（哪侧肺有结核病，则在哪侧肺结核副脉上表现）。（图76）

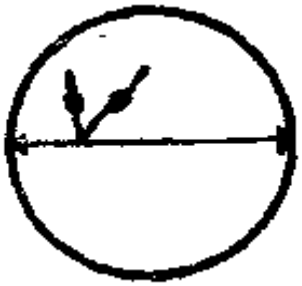


图 75

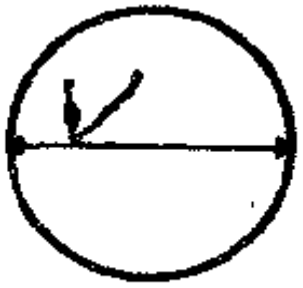


图 76

9.肺结核病灶纤维化脉象

若结核病灶形成了纤维化，则在肺主脉左侧下窜的副脉上，形成乱丝一样的形态脉象，脉仍四至。（图77）

10.慢性纤维空洞型肺结核脉象

如果结核病灶发展为晚期，则在肺主脉左侧下窜的副脉上出现有水泡型脉状（哪侧肺有空洞型结核，则在哪个副脉上出现），脉仍四至，如有炎症，则脉来五至。（图78）

图 77

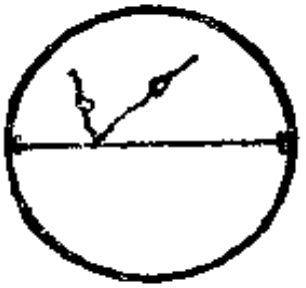


图 78

11.肺不张脉象

如果肺部粘连，则在肺主脉左侧下窜的副脉上出现平泡型脉象（哪侧肺有粘连，就在哪侧肺的副脉上出现）脉来四至。（图79）

12.肺气肿脉象

在肺主脉左侧出现的两条下窜的副脉上，如右侧肺气肿，则左边下窜副脉下端微粗而长，右边副脉不现；如左侧肺气肿，则左边向右下窜出的副脉下端微粗而长，左边副脉不现。脉仍四至。（图80）

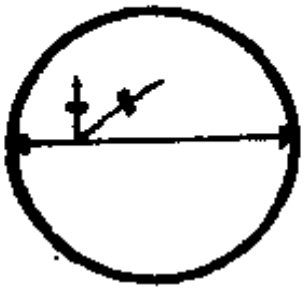


图 79

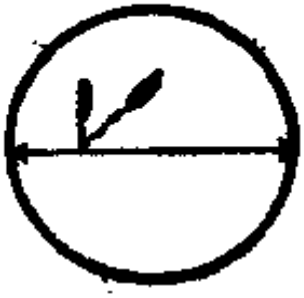


图 80

13.肺衰弱脉象

由于肺活量不足（男少于3500ml，女少于2500ml），肺主脉出现微弱无力的脉象，脉仍四至。（图81）

14.间质性肺炎脉象

若左侧肺有间质性炎症，则肺主脉左边，脉来五到六至；

若右侧肺有间质性炎症，则肺主脉右边，脉来五到六至。如果两肺上都有间质性炎症，则两肺主脉同来五到六至。（图82）

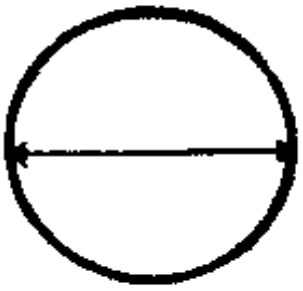


图 81

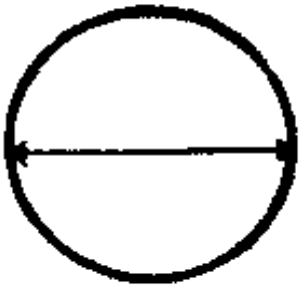


图 82

15.肺受寒邪脉象

若左侧肺有寒，则肺主脉左边脉来三至；若右侧肺有寒，则肺主脉右边，脉来三至。如果两肺都有寒，则两肺主脉同来三至。（图83）

16.肺脓肿脉象

若左侧肺有脓肿，就在左侧肺主脉上出现急促而洪大的脉象，脉来五到六至；若右侧肺有脓肿，就在右侧肺主脉上出现急促而洪大的脉象，脉来五到六至。如果两肺上都有脓肿，则两肺主脉同时出现急促而洪大的脉象，脉来五到六至。（图84）

17.左支气管炎脉象

该副脉在肺主脉的中心垂直向下窜出，形似细线，长约

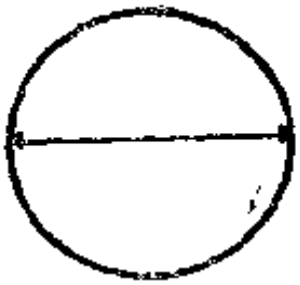


图 83

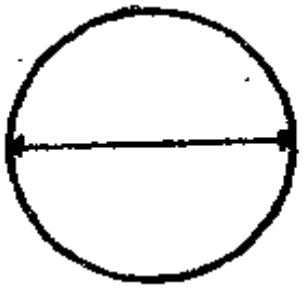


图 84

4 毫米，脉来五至。若切到此脉，则为左支气管炎。（图85）

18.右支气管炎脉象

该副脉在肺主脉的中心垂直向上窜出，形似细线，长约4毫米，脉来五至。若切到此脉则为右支气管炎。（图86）

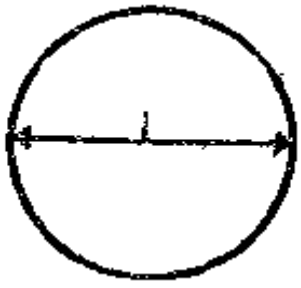


图 85

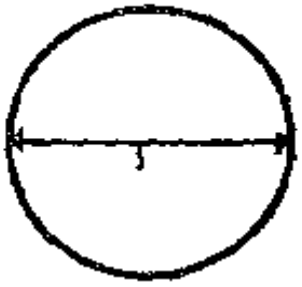


图 86

19.哮喘脉象

该病的诊断是以支气管炎脉象来鉴别，如果支气管炎副

脉粗而长，则近于哮喘；如果支气管炎副脉又粗又硬，则为轻度哮喘；如果支气管炎副脉不仅粗长，而且硬如石块者，则为严重的哮喘。（图87）

20.支气管扩张脉象

该副脉出现在肺主脉上部，右支气管炎副脉的右边，形似C形。脉来四至。如兼有炎症，则脉来五至。（图88）

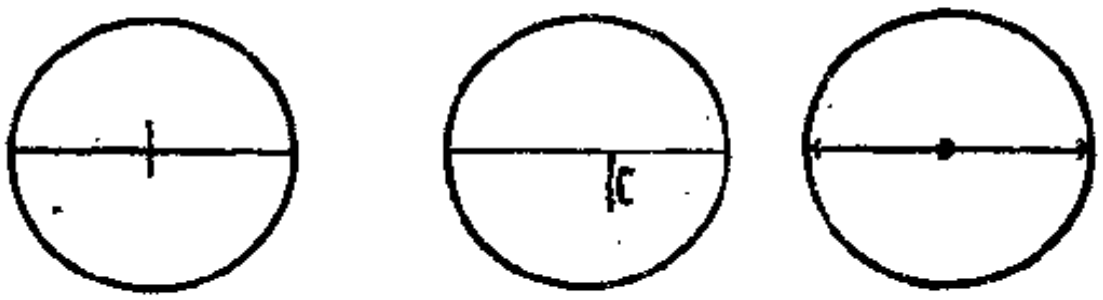


图 87　　图 88　　图 89

21.肺门炎脉象

该脉出现在肺主脉中心处，形似圆形，向上弹跳。脉来五到六至。若切到此脉，则为肺门发炎。（图89）

22.肺癌脉象

如肺部发生癌症，左右支气管和左右肺可能同时发炎，并在肺的上下左右某部有个病灶也发炎，这就是癌症的位置。如以上这些病症同时出现，脉来五至，癌症刚刚形成，如六

至则表示开始扩散，七至已完全扩散。（图90）

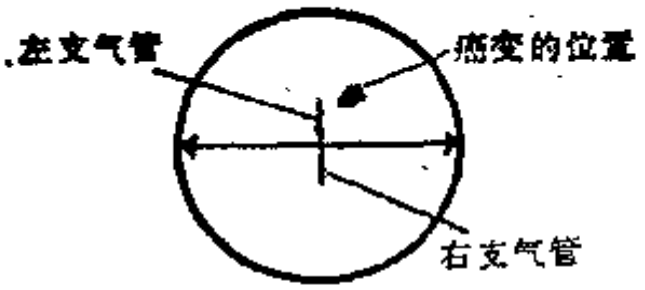


图 90

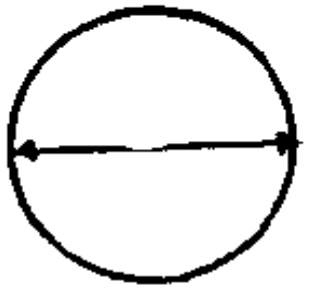


图 91

23.肺外伤脉象

若在肺部受过外伤者，则在肺脉上出现有不规则的疤结脉状，一般脉来四至，兼有炎症则五至。（图91）

五、肾脏脉象

1.肾脏正常脉象

肾脏的正常脉象是顺手臂方向上下活动的。肾脏主脉在人的一呼一吸中跳动四次（即脉来四至），并跳动有力，无副脉出现，则为肾脏的正常脉象。（图92）

2.急性肾炎脉象

若急性肾炎，则在肾主脉的下端出现一条较粗长的副

脉，向上跳动急促有力。脉来五至以上（图93）

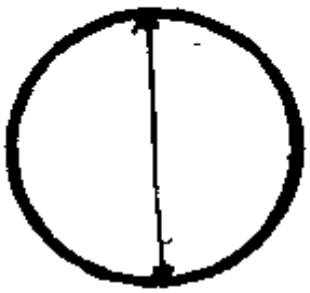


图 92

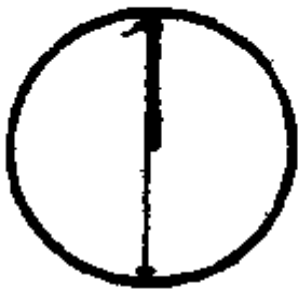


图 93

3.慢性肾炎脉象

若慢性肾炎，则肾主脉较粗，脉来五至。（图94）

4.急性肾盂肾炎脉象

若急性肾盂肾炎，则肾主脉的下端出现较粗长的副脉。脉来急迫六至以上。（图95）

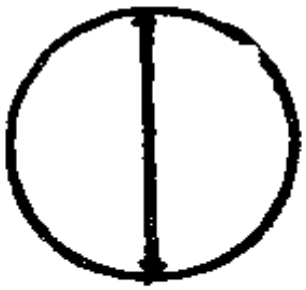


图 94

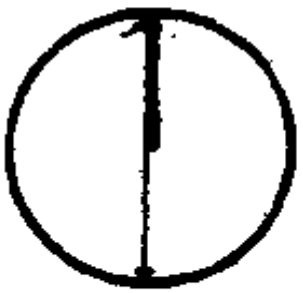


图 95

5.慢性肾盂肾炎脉象

若慢性肾盂肾炎，则在肾主脉的下端出现较粗短的副脉。脉来五至较急。（图96）

6.肾寒脉象

若肾家有寒（浮为表寒，沉为里寒），则肾主脉脉来三至。（图97）

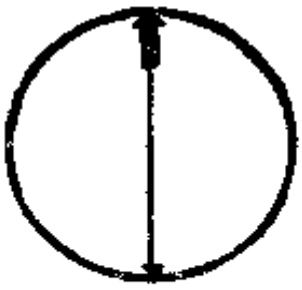


图 96

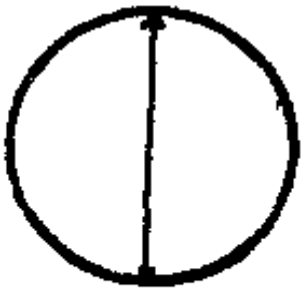


图 97

7.肾衰弱脉象

若肾脏衰弱，则肾主脉细微无力，脉来四至。（图98）

8.肾下垂脉象

该副脉出现在肾主脉的顶上端，有一种较粗的脉型向上窜出，若上窜1毫米，则肾下垂1厘米，以此类推。（图99）

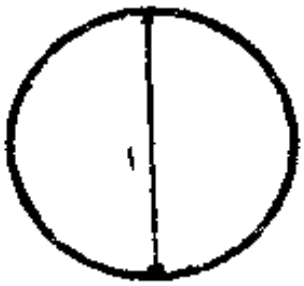


图 98

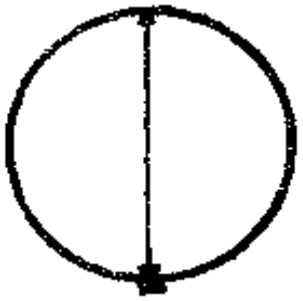


图 99

9.肾肿大脉象

若肾炎已久，则气血瘀积，必然导致肿大。此时肾主脉数大有力，脉来六至左右。（图100）

10. 肾积水脉象

若肾脏积水时，则肾主脉粗涩，仍为四至。（图101）

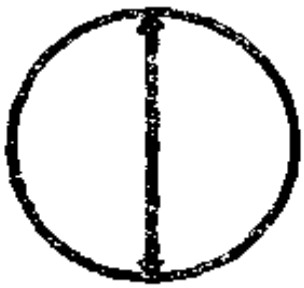


图 100

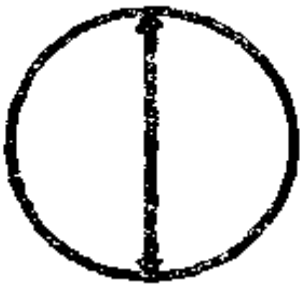


图 101

11. 肾结石脉象

在肾主脉上出现有不同形状的圆形或块形等副脉。脉仍

四至。（图102）

12. 肾中毒脉象

若肾脏中毒，在肾脉的平面上，出现从右向左转动较急的大环形副脉。（图103）

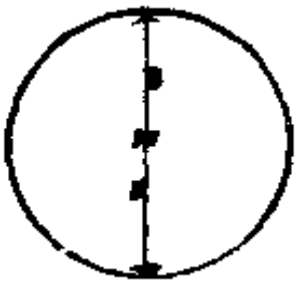


图 102

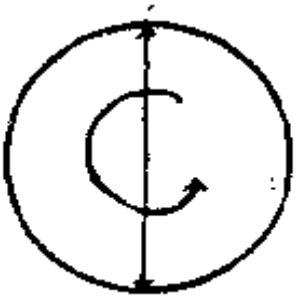


图 103

13. 肾外伤脉象

若肾脏受伤，则在肾脉底下有个木片似的副脉。一般脉来四至，兼有炎症则脉来五至。（图104）

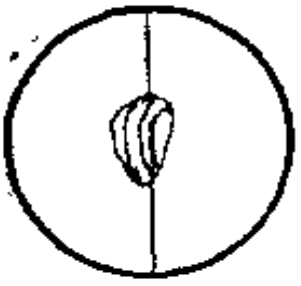


图 104

六、妇人脉象

1.月经不调脉象

月经正常与否，依切肝脉而定。若月经正常，则脉来四至；如果月经有寒，则脉来三至（月经衍期）；如果月经有热，则脉来五至（月经先期）；如果月经有寒又有热，则肝脉先跳五至，后跳三至（经期或前或后）。（图105）

2.闭经脉象

若月经闭塞，则肝脉有两个特点：一是在肝脉上端，有个块状副脉向上弹跳，并类似初孕副脉，但怀孕副脉为圆珠形，以此鉴别；二是肝脉或有或无。（图106、107）

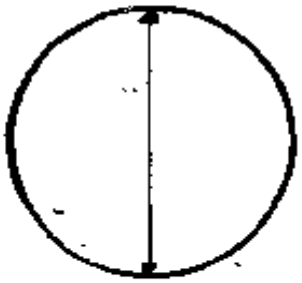


图 105

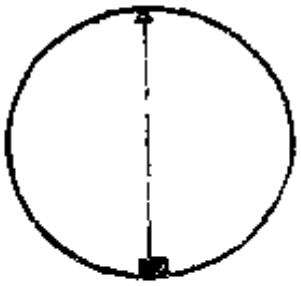


图 106

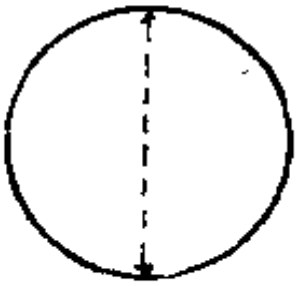


图 107

3.子宫内膜炎脉象

在肝主脉的顶上端，有个圆形副脉，轻则五至，重则六至以上。（图108）

4.子宫下垂脉象

在肝主脉的上端，伸出一条较粗的链形副脉（下粗上细）。如果子宫下垂2厘米，则副脉长约2毫米，由此类推。脉仍四至。（图109）

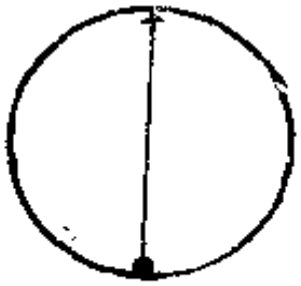


图 108

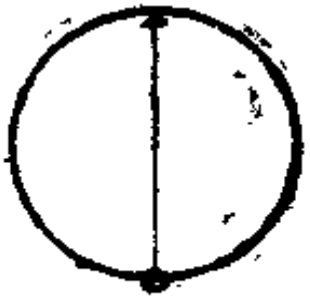
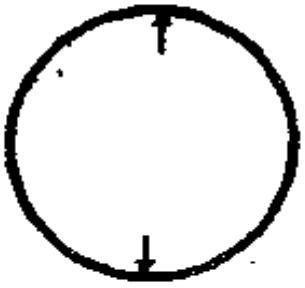


图 109

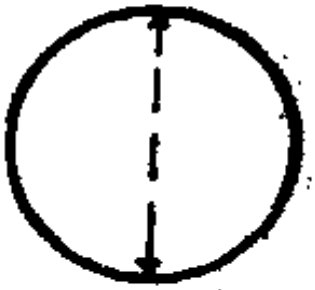
5.带证脉象

若妇人右肾之脉衰弱不起，而左肾之脉细微无力，则为带证（图110、111）。如果妇人两肾之脉衰弱无力，则为带



右肾脉

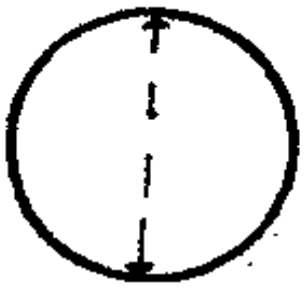
图 110



左肾脉

图 111

病已久，气血已亏。（图112、113）



右肾脉

图 112

左肾脉

图 113

6.妊娠脉象

妇人有孕时，初孕40天左右；则在肝主脉上端出现一颗毛珠形副脉。（图114）妇人若怀孕二三月后，则珠形脉下移二三毫米，毛形珠变为光形珠，并左右活动，脉来四至。（图115）如果怀孕六个月之后，这个圆形副脉就固定在肝主脉上端不滑动了。（图116）。

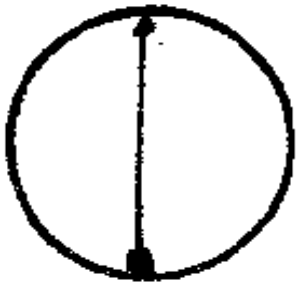


图 114

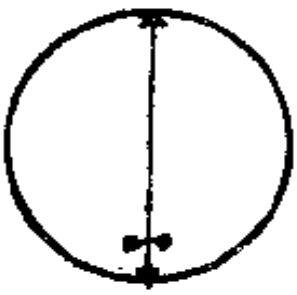


图 115

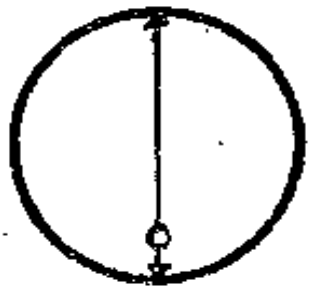


图 116

7.妇人胎损脉象

若妇人孕胎有损，则在肝脉中间的平面上出现一种环形副脉，其脉搏动较急（顺时针转动）。（图117）

8.产后风脉象

若妇人产后风，则肝脉弦数（图118），肺脉洪大。（图119）

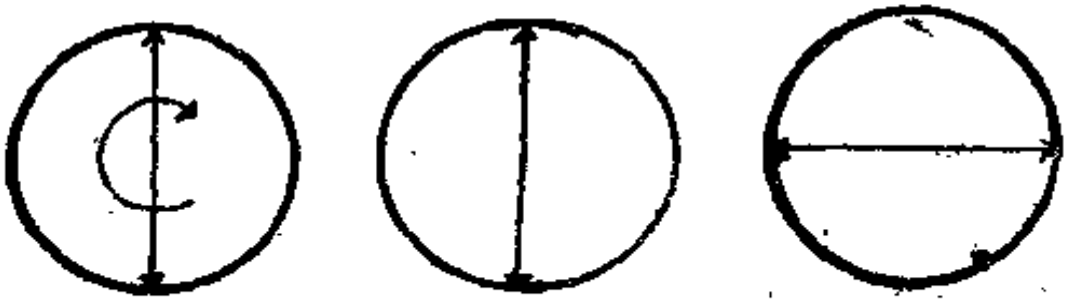


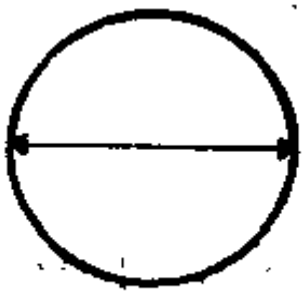
图 117　　图 118　　图 119

9.产后血崩脉象

产后初期血崩，则心脉洪，肝脉弱，久崩则六脉皆弱，还有浮洪现象。（图120、121）

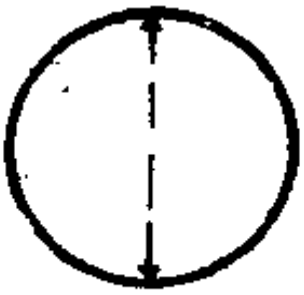
10.输卵管炎脉象

输卵管炎主症小腹疼痛，该副脉在小肠炎副脉上方，形似细线，左右活动，脉来至至。（图122）



心脉

图 120



肝脉

图 121

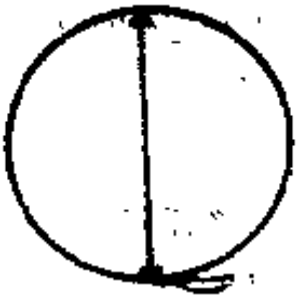


图 122

七、其他脉象

1.收缩压脉象

在心主脉左边有一条副脉下窜，则为收缩压(即高压)。

①如该副脉较细而软和者，则收缩压为14.7千帕（110mmHg）左右。（图123）

②如该副脉短而粗者，则收缩压为21.3～24千帕（160～

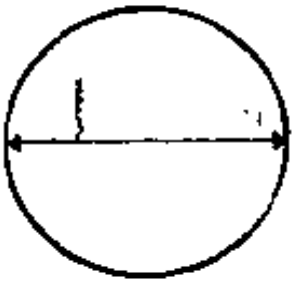


图 123

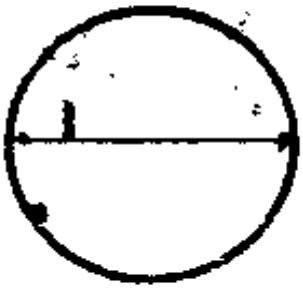


图 124

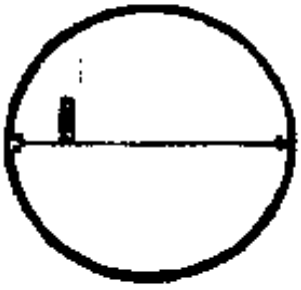


图 125

180mmHg）左右。（图124）

③如该副脉粗硬如石者，则收缩压为26.7～33.3千帕（200～250mmHg）左右。（图125）

2.舒张压脉象

该副脉出现在肝主脉中心处，形似1毫米大小的圆点状并向上弹跳，即为舒张压9.3千帕（70mmHg）。如果这个圆点状副脉从中心向下延伸1毫米，则舒张压为10.6千帕（80mmHg左右），延伸2毫米，则舒张压为12千帕（90mmHg左右），若延伸到桡骨上缘者，则舒张压为13.3千帕（100mmHg左右），若超过桡骨上缘者，则舒张压为14.6千帕（110mmHg左右）。如果这个圆点状副脉向上延伸1毫米，则为舒张压8千帕（60mmHg左右），如果向上延伸2毫米，则为舒张压6.7千帕（50mmHg左右）。（图126）

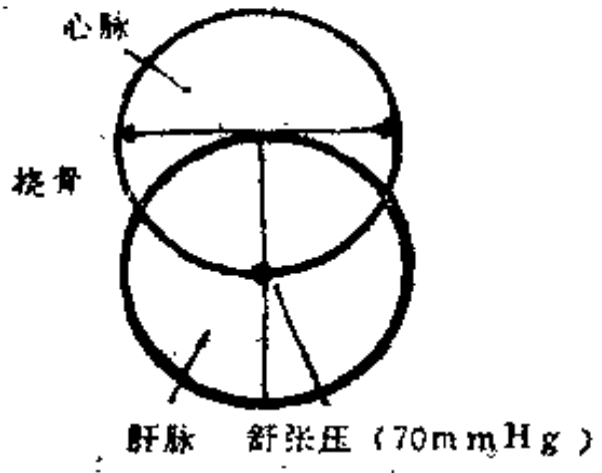


图 126

3.红细胞及贫血脉象

红细胞脉象，出现在肝主脉的右上侧，向下排列整齐，

形似小圆球状，每个小圆球，约1个毫米大小，并代表100万红细胞，没有形成的小圆球，代表50～80万红细胞。在切脉时，以此计算红细胞的多少（图127）。男性如果少于450万红细胞者，则为贫血，即小圆球形副脉在4个半以下（图128）。女性红细胞在350万以下，则为贫血，即小圆球形副脉在3个半以下（见图129）。

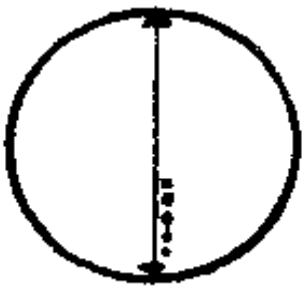


图 127

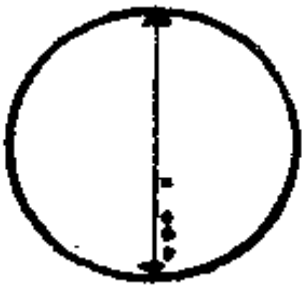


图 128

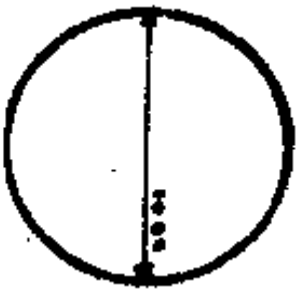


图 129

4.胰腺炎脉象

该副脉出现在胃主脉的下部，由右下向左上倾斜，形似一条线状，疼痛症状时尤明显。脉来五至。（图130）

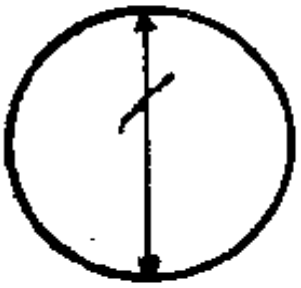


图 130

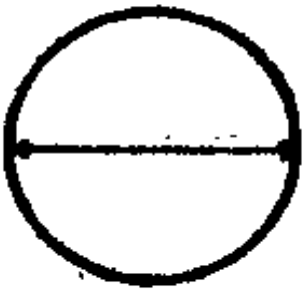


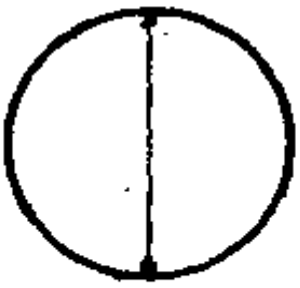
图 131

5.高热脉象

衡量体温，以肺脉为主。如肺主脉五至，则体温为38度；如肺主脉六至，则体温39度。如果肺脉每增加一至，则体温就升高1度，由此类推来断定高热。（图131）

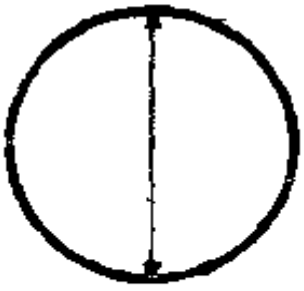
6.疟疾脉象

疟疾发作时，热则肝肾之脉弦数，寒则肝肾之脉弦迟，其余之脉正常。（图132、133）



肝脉

图 132



肾脉

图 133

7.胸膜炎脉象

①该副脉出现在肺主脉左侧，形似细线，向上窜出，脉来五至。若切到此脉，则为右侧胸膜发炎。（图134）

②该副脉出现在肺主脉右侧，形似细线，向上窜出，脉来五至。若切到此脉，则为左侧胸膜发炎。（图135）

③若在肺主脉左右两侧都有一条形似细线的副脉向上窜出，脉来五至，则为左右胸膜皆发炎。（图136）

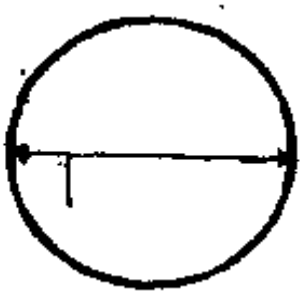


图 134

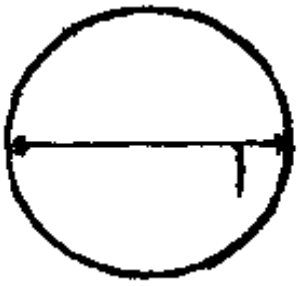


图 135

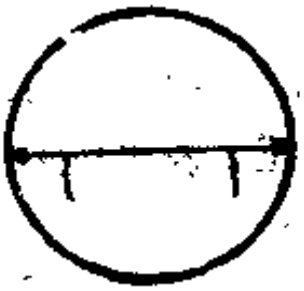


图 136

8.腹膜炎脉象

该副脉出现在胃脉的上端，形似一条细线（比大小肠脉象稍细一点），左右活动，脉来五至。若切到此脉，则为腹膜炎。（图137）

9.膀胱炎脉象

在右肾主脉的顶上端，出现一条上窜的副脉，长约4～5毫米，比肾下垂脉细长些（并以此来鉴别这两种副脉）。

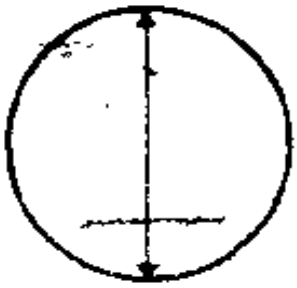


图 137

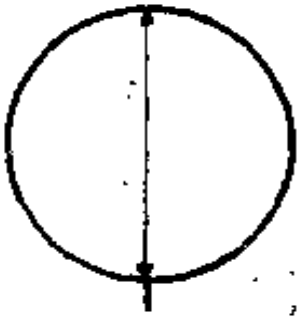


图 138

若切到此脉，则为膀胱炎。（图138）

10.膀胱结石脉象

在肾主脉顶端之外，出现一种块状或圆形的副脉，脉来四至。若切到此脉，则为膀胱结石。（图139、140）

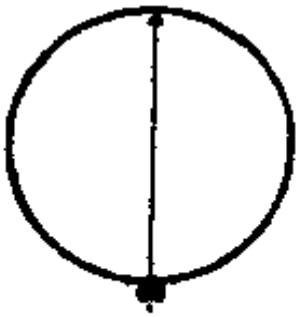


图 139

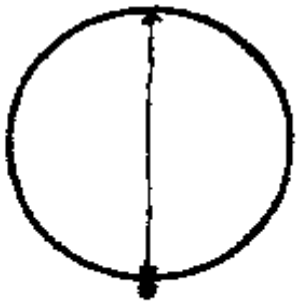


图 140

11.前列腺炎脉象

①若左侧前列腺发炎，则右手肾脉的上端左边出现一条向上窜的细线形副脉，脉来五至。（图141）

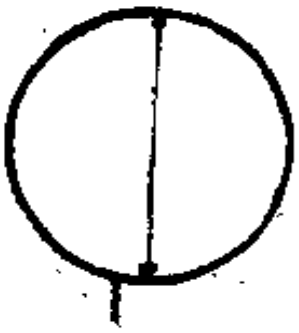


图 141

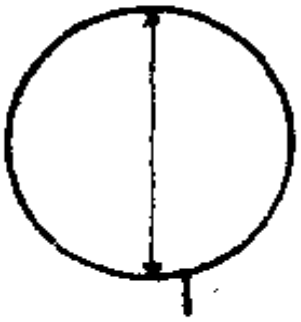


图 142

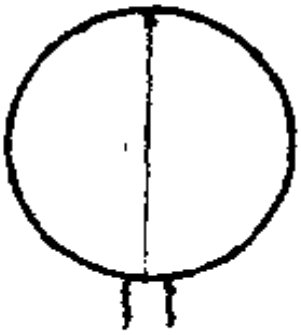


图 143

②若右侧前列腺发炎，则右手肾脉的上端右边出现一条向上窜的细线形副脉，脉来五至。（图142）

③若左右两侧前列腺都发炎者，则在右肾脉上端的左右两侧前列腺副脉同时出现，两脉同来五至。（图143）

12.左右前列腺和膀胱发炎脉象

若左右前列腺和膀胱都发炎者，则右肾脉上端左右前列腺炎和膀胱炎三条上窜副脉皆出现，脉来五至。（图144）

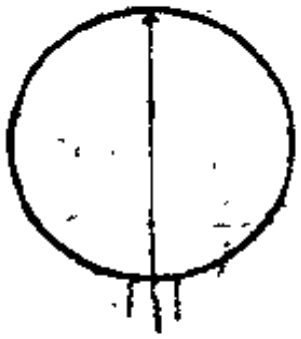
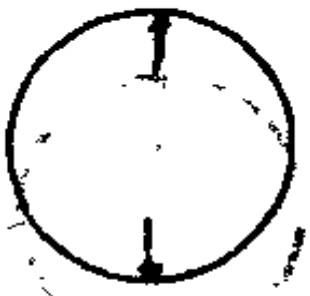


图 144

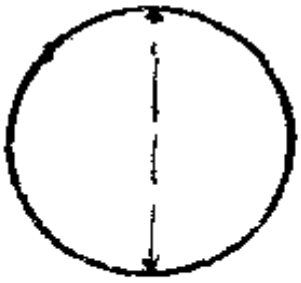


左肾脉

图 145

13.阳痿脉象

如果男子左肾之脉衰弱不起，而右肾之脉微弱无力，则为轻度阳痿。（图145、146）



右肾脉

图 146

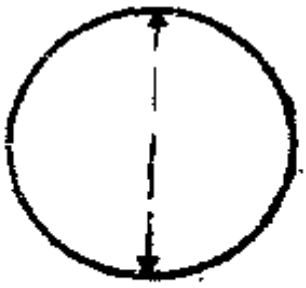


图 147

如果男子两肾之脉都衰弱不起，似有似无，断断续续，证明阳痿已久，精血已枯。（图147、148）

14.精神病脉象（包括癫病、癫痫、精神分裂症等）

凡有精神病者，则在心脉的上端与肝脉的下端交界处有个小圆形副脉，脉来四至。若切到此脉，则为精神病患者。（图149）

图 148

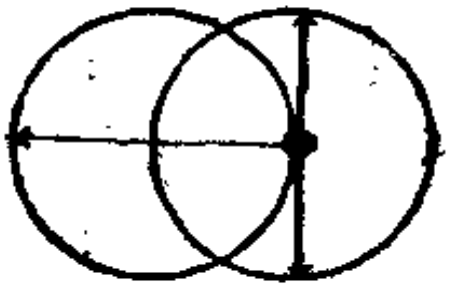


图 149

附录

临床经验选编

一、临床用药原则

中医治病，除针灸、推拿外，必须用中草药以治之，但用药必须考虑寒热温凉平之性能；其次，根据药物的具体性味，如酸甜苦辣咸等，并研究其化学成分，合理配成方剂，效果一定良好；还要根据春夏秋冬因时因人之异，男女老幼身体强弱之不同下剂量。处方时大凉、大热、大燥之药要慎用，有毒之药不能轻易用之。

二、临床治疗大法

概言之，要注意以下几点：

1.综合治疗，重点进攻，所谓“围点打援”。

2.根据轻重缓急，各个击破，治此病暂留彼病，分而治之。

3.中西医结合。

4.阴虚补血，阳亢滋阴，表病以解，里病以调，虚以轻补，实以缓下，虚不能泻，泻则中脱，实不能补，补则塞死。

三、对患者的要求

1.患者按医生规定的要求服药，不能随意增减。

2.在服药期间，忌吃公鸡、鲤鱼、猪头肉、辣椒，慎房事。

3.用药一般宜新不宜陈，如果药物变质，发霉，生虫决不能用。

四、临床常用方（52则）

下面介绍本人在临床中行之有效的方剂。但这只是个人的经验，临床实践中并非一成不变，仅供读者参考。一般每剂药煎服两次，分上、下午服。

1.风湿性心脏病

治则：祛风利湿，养心安神。

处方：薏以仁10克　杭白芍10克　当归10克　秦艽10克　黄连15克　柏子仁10克　生牡蛎10克　焦白术10克　龙骨15克　甘枸杞10克　羌活12克　防风12克　泽泻12克　茵陈12克

按：本方服剂数酌情而定，一般服10剂可见效。

2.冠心病

治则：行气活血化瘀

处方：川芎10克　丹参10克　五谷虫12克　细木通12克　生牡蛎15克　草决明12克　山萸肉10克　石膏15克　知母10克　川断10克　枸杞12克　红花10克　焦白术10克　车前子10克　陈皮10克　薏仁10克

按：本方服10剂到20剂左右可愈或见效。

3.二尖瓣狭窄

治则：祛风利湿、补心安神

处方：羌活12克　防风12克　木通15克　泽泻12克　竹叶30片　芦根10克　海风藤15克　追地风15克

秦艽10克　苍术6克　远志肉12克　莲子肉12克

按：本方可先吃30帖，观察疗效。

4.左、右心房肥大

治则：化瘀、清心、安神

处方：茵陈12克　细木通10克　芦根30克　竹叶5克　当归10克　柏子仁12克　陈皮10克　草决明12克　生牡蛎10克　川芎10克　海风藤10克　黄连12克　红花10克　防风10克

按：本方服10剂到20剂左右可愈。

5.心肌炎

治则：祛湿、清心、化瘀

处方：黄芩15克　芦根10克　竹叶5克　麦冬10克　龙骨15克　当归10克　黄连12克　红花10克　桔梗10克　柏子仁12克　知母10克　土伏苓10克

按：本方服10剂左右可见效果。

6.寒性肝炎

治则：健脾土、祛寒湿、平肝消炎

处方：茵陈15克　川继断10克　石决明15克　甘枸杞10克　川郁金10克　薏以仁10克　上肉桂10克　全当归10克　车前子10克　杭白芍10克　焦白术10克　佛手干10克

7.肝炎合并肝肿大

治则：养肾平肝、和胃利湿、清脑安神、消炎止痛

处方：用寒性肝炎方，焦白术改用生白术10克，加肥知母、甘草各10克。如肝肿大者加生牡蛎12克，再加乳没药各12克。

8.黄疸性肝炎

治则：疏胆道排积热，健脾养肾止痛

处方：仍用寒性肝炎处方加龙胆草20克、细木通12克、地丁15克、蒲公英15克、香白芷12克即可。

9.肝硬化

治则：行气破瘀通经、滋肾养肝止痛

处方：茵陈15克　香白芷10克　姜黄10克　肉桂10克　川芎10克　生白术10克　乳没药各10克　全当归10克　杭白芍10克　川郁金10克　石决明15克　川续断10克　甘草10克　大蒜子10头

按：本方服20剂左右可见效。

如肝肿大明显

治则：疏肝理气、活血化瘀

处方：茵陈15克　防风10克　白芷10克　当归10克　川芎10克　生牡蛎15克　石决明12克　郁金10克　白术10克　石斛12克　枸杞12克　乳、没药各10克

10.胆囊炎

治则：理气，活血止痛，滋肾平肝

处方：乳没药各10克　焦白术10克　枸杞10克　龙胆草20克　川芎10克　生地黄10克　肥知母15克　全当归10克　甘草10克　石决明15克　茵陈15克　郁金12克

按：轻则10剂左右，重则20剂左右。

11.肝下垂

治则：柔肝养阴、补肾益气

处方：合欢皮12克　甘草6克　首乌12克　川断12克　五味子9克　寄生12克　杭芍12克　当归10克　海螵蛸10克　生牡蛎15克　黄芪15克　升麻15克

12.肾炎

治则：强肾利水，活血行气

处方：杜仲10克　川续断10克　抚川芎10克　车前子10克　山栀子10克　甘枸杞10克　小茴香10克　乳、没药各10克　威灵仙10克　当归10克　焦白术10克　陈皮10克　泽泻10克

按：本方轻则服5剂，重则10剂左右即见效。

13.肾盂肾炎

治则：补肾行气利湿

处方：地榆炭12克　白茅根10克　玄参9克　骨碎补12克　巴戟天12克　淮牛膝12克　木通10克　杜仲10克　川续断12克　当归10克　车前子12克　小茴6克　乳、没药各10克

按：服15剂～20剂左右。

14.肾结石及膀胱、尿道结石

治则：补肾通淋

处方：黑元参10克　川杜仲10克　全当归10克　山栀子10克　川续断10克　乳没药10克　薏以仁10克　甘枸杞10克　焦白术10克　酸枣仁10克　合欢皮10克　车子前10克　细木通10克　金钱草30克

15.肾脏虚寒

治则：补肾、活血祛寒

处方：杜仲12克　川断12克　小茴6克　当归10克　威灵仙12克　川芎9克　补骨脂10克　骨碎补6克　枸杞12克　桂枝10克　肉桂10克

16.肾亏

治则：温肾补气

处方：当归10克　龟版30克　黄芪10克　党参10克　巴戟天12克　骨碎补12克　威灵仙12克　附子10克　大云10克　杜仲10克　熟地15克

按：久亏服20～30剂，一般服10剂左右。

17.肾下垂

治则：补肾、益气、健脾

处方：合欢皮10克　黄芪15克　党参10克　骨碎补6克　大云10克　芡实12克　乌贼骨12克　升麻12克　当归10克　杜仲10克　枸杞10克　川断12克

按：服10～20剂。

18.白带

治则：健脾祛湿、补肾壮腰

处方：车前子15克　小茴6克　海螵蛸10克　山萸肉12克　川芎9克　灵仙12克　川断12克　补骨脂10克　枸杞12克　当归10克　毛姜10克　党参12克

19.肾积水

治则：强肾利水

处方：茯苓10克　姜皮10克　大腹皮10克　车前子12克　威灵仙12克　杜仲12克　大云12克　牛膝12克　当归10克　首乌10克　枸杞12克

20.肺间质炎及肺门炎、肺炎、左右支气管炎

治则：健脾润肺祛湿

处方：黄芩15克　当归10克　羌活10克　防风10克　党参10克　炙冬花10克　炙紫菀12克　陈皮10克　焦白术10克　知母12克　制半夏10克　枳壳10克

21.肺气虚寒

治则：补肾温肺，祛风利湿

处方：荆芥10克　防风10克　桂枝10克　桔梗10克　葶苈子10克　当归10克　熟附子10克　山萸肉10克　光仁10克　炙冬花12克

按：服5～10剂。

22.肺结核

治则：健脾补肺

处方：干茵陈15克　汉防风10克　焦白术10克　绵黄芪10克　光杏仁11克　鸡肉金10克　广陈皮10克　马兜铃10克　金当归10克　阿胶10克　炙紫菀12克　制半夏10克　炙冬花12克

23.肺浓肿

治则：补气活血，解毒排脓

处方：黄芪15克　香附子12克　香白芷12克　乳、没药各12克　黄芩15克　炙冬花12克　天门冬12克　全虫5克　蜈蚣3条　银花15克　甘草10克　当归12克

按：服10剂。

24.胸膜炎

治则：行气活血，平肝利水

处方：羌活10克　防风10克　黄芩15克　知母12克　葶苈子12克　当归10克　川芎9克　阿胶15克　黄柏15克　石决明15克　干姜10克　枳壳10克　土茯苓12克

按：轻则10剂，重则20剂。

25.肺气虚弱

治则：健脾润肺补气

处方：黄芪15克　党参12克　太子参20克　炙紫菀12克

炙冬花12克　川贝母10克　阿胶10克（另包）　当归10克　陈皮30克　益母草30克

按：轻则10剂，重则20剂。

26.膀胱炎

治则：清热利湿

处方：茅根10克　玄参10克　木通10克　枸杞15克　川断12克　杜仲12克　玉米15克　当归10克　党参10克　金钱草10克　威灵仙12克　车前子30克（另包）

按：服5～10剂。

27.膀胱结石

治则：清热利湿通淋

处方：车前子30克（另包）　玄参10克　当归10克　川芎10克　川断12克　郁金12克　滑石20克　金钱草40克　大云15克　乌梅10克　梔子12克　海金砂20克

按：服10～15剂。

28.阳痿

治则：滋阴补肾

处方：阳起石15克　川断12克　杜仲12克　枸杞12克　柏子仁12克　当归10克　玄参15克　鳖甲30克　黄柏12克　生地20克　石斛12克　天门冬12克　石决明20克　车前子15克（另包）

按：新病服10剂，久病服至30剂

29.产后风

治则：化瘀祛风解痉

处方：防风10克　竹叶3克　胆星20克　坤草15克　合

欢皮10克　党参10克　当归10克　首乌10克　茅根炭10克　苍蒲15克　鸡血藤10克　红花10克　茵陈10克

按：服3～5剂。

30.保胎

治则：杜肾安胎、养气安神

处方：山萸肉10克　当归10克　杜仲12克　益母草30克　莲子肉10克　党参10克　黄芪15克　龙骨15克　枣仁12克　牛膝12克　麻黄根10克　柏子仁12克

按：服5剂左右。

31.闭经

治则：活血化瘀、补肾通经

处方：桂枝10克　牛膝10克　三棱10克　肉桂10克　鸡血藤10克　小茴10克　当归10克　灵仙10克　焦白术10克　陈皮10克　香附12克　补骨脂10克　红花10克

按：服5～10剂

32.子宫炎

治则：清热利湿

处方：坤草15克　石决明15克　郁金10克　茅根10克　生地10克　枸杞12克　灵仙12克　银花20克　车前子15克

按：服5～10剂。

33.子宫下垂

治则：补气升提、滋肾养阴

处方：合欢皮10克　党参15克　黄芪15克　川断10克　枸杞12克　当归10克　牛膝10克　海蛸10克　首

乌10克　山萸肉12克　木香6克　升麻10克

34.月经提前

治则：理气调经，活血养血

处方：石决明15克　郁金10克　陈皮10克　白术10克　知母10克　当归10克　川芎9克　茵陈10克　红花10克　木通10克　瓜络10克　香附10克

按：新病服5剂，久病服10剂以上。

35.月经退后

治则：温经补肾养血

处方：当归10克　红花10克　川芎9克　郁金10克　赤白芍10克　牛膝10克　桂枝10克　枸杞12克　川断10克　威灵仙10克　干姜10克　香附10克

按：一般服5剂即可，久病服10剂以上。

36.经期或前或后

治则：补肾调经

处方：石决明15克　生牡蛎15克　当归10克　丝瓜络10克　香附10克　红花6克　威灵仙12克　陈皮10克　桂枝10克　淮牛膝10克　佛手干12克　甘草10克

按：一般服10剂左右可愈。

37.经痛不孕

治则：行气化瘀止痛

处方：女贞子10克　全当归10克　广陈皮10克　丝瓜络10克　焦白术10克　合欢皮10克　京三棱10克　抚川芎10克　香白芷10克　香附子10克　乳、没药各10克　潞党参10克、紫石英10克　大麦芽10克

按：一般服10剂即可，久病服20剂。

38．高血压及主动脉硬化、脑动脉硬化、脑血栓、冠心病

治则：潜阳、清热、化瘀通脉

处方：红花6克　生石膏20克　茵陈10克　川芎6克　薏以仁10克　石决明15克　木香5克　车前子10克　细木通10克　知母10克　五谷虫15克　焦白术10克　甘草10克

按：初期高血压服25剂，中期高血压服30剂，晚期高血压服50剂，脑血栓加三棱10克，姜黄10克。

39．心力衰竭

治则：回阳益气固脱

处方：莲子肉10克　远志肉10克　焦白术10克　全当归10克　五味子15克　枸杞10克　龟版20克　柏子仁10克　益母草15克　炙紫菀10克　黄芪10克　陈皮10克　合欢皮12克

按：服60～100剂。

40．肺气肿哮喘

治则：温肺补气平喘

处方：麻黄12克　细辛6克　干姜10克　黑附子10克　火麻仁12克　葶苈子12克　炙兜铃12克　炙冬花12克石决明12克　瓜络12克　姜黄12克　当归10克川芎10克　香白芷12克　淮牛膝10克　焦白术10克

按：卧床不起者，须服40帖左右。

41．血小板减少

治则：益气养阴、活血补血

处方：红花6克　侧柏叶10克　白芨片10克　陈皮10克　川芎10克　茅草根10克　龟版30克　银花10克　全当归10克　阿胶10克　甘草10克　益母草12克　焦白术10克

按：轻症10剂，重症15剂，病期1年以上者难治。

42.脑震荡

治则：理气活血、强脑安神

处方：明天麻10克　全当归10克　桂枝12克　潞党参10克　白菊花10克　绵黄芪10克　焦白术10克　朱伏神10克　香附子10克　鸡血藤10克　合欢皮10克　姜蚕10克　制草乌10克　香白芷10克　荆芥10克

按：15剂左右可愈（但必须先服十全大补汤10剂后再服此药）。

43.胰腺炎

治则：行气活血、清热、凉血

处方：川芎10克　红花10克　肉桂10克　知母12克　甘草10克　石膏20克　焦术10克

按：服10～15剂左右可愈。

44.乳糜尿、血尿

治则：活血逐瘀，补气养血

处方：白茅根10克　绵黄芪12克　紫丹参10克　侧柏叶10克　五谷虫12克　潞党参10克　全当归10克　淮山药10克　杭川芎10克　白芨片10克　细木通10克　鸡内金10克

按：服10剂左右可愈。

45.两踝骨骨刺

治则：祛风活血，强筋健骨

处方：全当归10克　骨碎补10克　香白芷10克　薏以仁10克　虎骨1克　绵黄芪10克　五谷虫12克　羌活10克　新龟版30克　地鳖虫15个　川杜仲10克　补骨脂10克合欢皮10克　橘络10克

按：先针灸一个时期，吃风湿性关节炎药酒10斤。10天后，每天饭后吃1小杯药酒，药酒后再服此药。忌吃刺激物，忌吃助湿食物，忌吃发物。服10～15剂即见效果。

46.椎骨增生

治则：强筋健骨，祛风利湿，理气活血

处方：全当归10克　薏以仁10克　粉甘草12克　香附子10克　汉防风10克　淮牛膝10克　细木通10克　绵黄芪6克　龟版30克　香白芷10克　焦白术10克　五加皮10克　川杜仲10克　桑寄生10克

按：另外加吃小鸡爪60副，在冬令进丸吃，可与中药同时用。每天晚饭后煮吃6副，加红糖、红枣、小红豆各半斤，一起煮烂吃下，鸡爪子骨聚起来炙黄研粉，和生黑芝麻3斤、米3斤（磨粉）拌和一起，每天饭后吃二小勺。椎骨骨裂者也可用此方，忌受冻受潮湿，忌吃发物。轻则20剂，重则40剂可愈。

47.发育不良

治则：补肾健骨，补气补血

处方：全当归10克　焦白术10克　宣木瓜10克　龟版30克　合欢皮10克　五加皮12克　骨碎补10克　桂枝10克　益母草15克　白芨片10克　绵黄芪15克　杜仲12克　红花6克　鸡内金10克　地鳖虫15个　淮牛膝10克　五谷虫10克

按：忌吃发物及刺激物，服15剂左右即愈。

48.糖尿病

治则：滋阴补肾、调剂泌尿系统，增强肾功能

处方：巴戟天10克　川杜仲10克　全当归10克　绵黄芪10克　甘枸杞10克　兔丝子10克　淮牛膝10克　川续断10克　车前子10克　丝瓜络10克　细木通10克　何首乌10克　合欢皮10克　泽泻10克

按：忌吃高糖、高淀粉，忌吃发物。轻则30剂，重则50剂可愈。

49.前列腺炎

治则：清热利湿

处方：白花蛇草50克　蒲公英15克　紫花地丁15克　炒黄柏15克　车前子15克　灵仙10克　玄参12克　川断12克

按：服10～15剂可愈。

50.失眠症

治则：养心安神

处方：全当归12克　潞党参10克　酸枣仁10克　甘枸杞10克　蒸首乌10克　焦白术10克　佛手干10克　川杜仲10克　龙骨15克　炙紫菀10克　朱伏神10克　夜交藤10克绵黄芪12克　合欢皮10克

按：忌吃刺激物，忌房事，忌吃发物。

51.风湿性筋骨痛

治则：祛风利湿、温经通络

处方：红参须30克　木瓜片15克　白芍15克　川乌6克　五加皮10克　广木香6克　炒于术6克　红枣12克　狗脊15克　杜红花6克　秦艽10克　生白术

15克　生姜黄12克　干地龙6克　龟版10克　鲜生姜15克　乳香6克　桑枝12克　海风藤12克　落得打12克　制没药6克　丝瓜络15克　伸筋草10克　桑叶12克　木防己6克　寻骨风15克　归尾15克　广三七6克　炙甘草12克　麻黄15克　草乌6克　肉桂15克

按：此药用白酒5斤泡数星期后，早晚各服1次，每次1小杯；不愈再泡1次，效果良好。

52.乳痛

处方：银花12克　地丁10克　全蝎5个　甘草12克　乳没药各10克　丁香6克　通草12克　丝瓜络10克　木香6克　蜈蚣3个　白芷12克　当归12克　川芎10克

五、临床小验方

1.肝腹水

猪肚1个洗净，大蒜适量装猪肚子里，放锅里煮烂。将猪肚切片，不能放盐，分两天吃完。吃两个后即见效。忌盐百天。

2.久疟不愈

用当归30克，白术30克，煎服二次可愈。轻则酌减。

3.病后脱发

先用明矾水将头洗净，用生姜片擦，擦至不痒为止。再用生芝麻2斤磨粉和蜂蜜2斤拌和一起，每次饭后吃2勺，吃完即有效。如再注射胎盘组织液更好。

4.神经性皮炎（包括风癣、疥癣等）

先用生姜半斤切碎，放在酒精里浸几天，再用生姜片蘸

酒精汁搽，每日搽1、2次，多搽几次也可。搽之后，再用银花、甘草、地骨皮、细木通烧水洗。如是局部病变可烧水熏洗，用药量少，不宜太多；如是全身病变，要烧水洗浴，药量可多一些。具体地说，局部病变取上药各样200克，每次20克即可；如系全身病变，上药各样500～1000克，每次烧水取各药50～100克。洗过的水留下，再烧再洗，洗至一周左右可愈。

5.胃溃疡（包括球部、十二指肠、贲门、幽门溃疡）

A.用皮蛋10余个，蛋要放在火炉上烤，先将泥壳烧炸裂，再将蛋里水气烘干吃下，每日吃2个（早晚吃），在两小时内不能饮开水。

B.用仙人掌（不老不嫩）煎开水吃，第一次吃水，煎第二次连仙人掌也吃掉，大约吃10余次左右可愈。如把仙人掌和皮蛋同时使用，效果更好。

6.急性黄疸性肝炎

用茵陈200克，白酒2小杯，先将茵陈放水煮好，将酒冲服，服1～2次可愈。

7.全身痒痛

用蜂房4、5克，煎2个鸡蛋，吃3～4次，即见效。

8.疔疮

A.苍耳虫浸麻油外用，同时可将苍耳虫敷在疔疮上，纱布扎好（苍耳虫可在苍耳杆子里找到）。

B.用银花9克，野菊花9克，地丁9克，蒲公英12克、天葵12克，煎开水，一日服3次，服几次即愈。

9.月经不调

用蚕砂120克，大酒250克，浸1周后，每天饭后炖温吃1小杯，吃完可愈。

10.内伤

用寻骨风（即黄木香）二枚，广三七12克，猪蹄2个，煮吃2～3次可愈。

11.实痰

用冰糖2斤、白果2斤、每天各取30克，煮烂吃下，吃完可见效。

12.头风

制草乌6克、制川乌6克、香白芷9克、姜虫9克、甘草9克。上药研末，分9小包，日服3次，每次1包，3日服完。

13.身体枯瘦

在三九天，用猪骨煨汤，放赤豆、红枣、红糖各250克，煮烂后盛入盆内，早晚煮吃一小杯，吃若干天后身体自强、精神自旺。

14.秃头

先将秃疥疤剃掉，用盐开水待温后将头洗净。用胡椒粉60克、陶土60克（即黄瓦盆末子）、蜡烛90克、红糖60克，拌匀敷在头上，几天后不痒去掉可愈。

15.坐骨神经痛

用电炉将痛处薰热，擦上生母鸡油，把鸡油烤干，连烤几次即愈。

16.烫伤

以生石灰过滤的水和芝麻油搅拌，变成鸡蛋清样，涂在患处，15分钟内见效。

17.膝疮腿

用指甲花、苏子，连枝带叶捣烂，再放29克明矾在一起拌和，敷在患处，用纱布包好10天后去掉，然后再包一次可

不复发。

18.破伤风

用金针在两手臂曲池穴上刺2针，不待酸即起针。用大蒜切成片，放在针眼上面，再用艾炷放在大蒜片上燃着灸之。各灸7次，连灸几晚上即愈。如破伤风伤口在下肢，就针双足三里穴位，按上述办理效果特好。如果角弓反张、牙关紧闭时，可用南星15克、防风15克，竹叶7片煎开水，灌服2剂可愈。

19.蜂窝组织炎

艾水洗净患处，用胡椒粉撒上，再用胶布固定，2天换1次，2～3次可愈（如将胡椒粉换成辣椒粉效果更好）。

20.带状疱疹

用生猪油擦几次即见效。